
Pacientes com Necessidades Especiais

Aula

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 1

Conteúdo original: @odontoisadora | Adaptado e diagramado por OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Pacientes com Necessidades Especiais	3
02 Pacientes com Necessidades Especiais (parte 2)	7
03 Pacientes com Necessidades Especiais (parte 3)	11
04 Pacientes com Necessidades Especiais (parte 4)	15
05 Pacientes com Necessidades Especiais (parte 5)	20
06 Pacientes com Necessidades Especiais (parte 6)	23
07 Pacientes com Necessidades Especiais (parte 7)	27
08 Pacientes com Necessidades Especiais (parte 8)	32
09 Pacientes com Necessidades Especiais (parte 9)	36
10 Pacientes com Necessidades Especiais (parte 10)	41
11 Pacientes com Necessidades Especiais (parte 11)	45
12 Pacientes com Necessidades Especiais (parte 12)	50
13 Pacientes com Necessidades Especiais (parte 13)	53

01

AULA

Pacientes com Necessidades Especiais

Aula ministrada pela Prof Dra Nathália T. Duarte, na Universidade Cidade de São Paulo.

Qual a implicação clínica odontológica, **Bibliografia:** *Interpretação de Exames Laboratoriais Wallach - 10Ed*

Todo PCD é PNE, mas nem todo PNE é PCD.

Podemos dividir o PNE em:

PONTOS-CHAVE

- Doenças infectocontagiosas
- Doenças sistêmicas e crônicas

Interpretação de exames laboratoriais

Quando solicitar um exame? Isso define e melhora o planejamento e a atuação na clínica.

Principais exames

Hemograma: vemos sangue. Tem a informação das células de defesa, se o paciente tem anemia, plaquetas (vemos apenas no hemograma)

Pergunta importante: Quando eu tenho um paciente anticoagulado (paciente que teve um evento tromboembólico na vida), e o médico pensa que deixa o sangue "mais fino", ou seja, menos viscoso. Quais são os exames que tenho que pedir para o paciente para atender com mais segurança 1. **Coagulograma:** ver a cascata de coagulação.

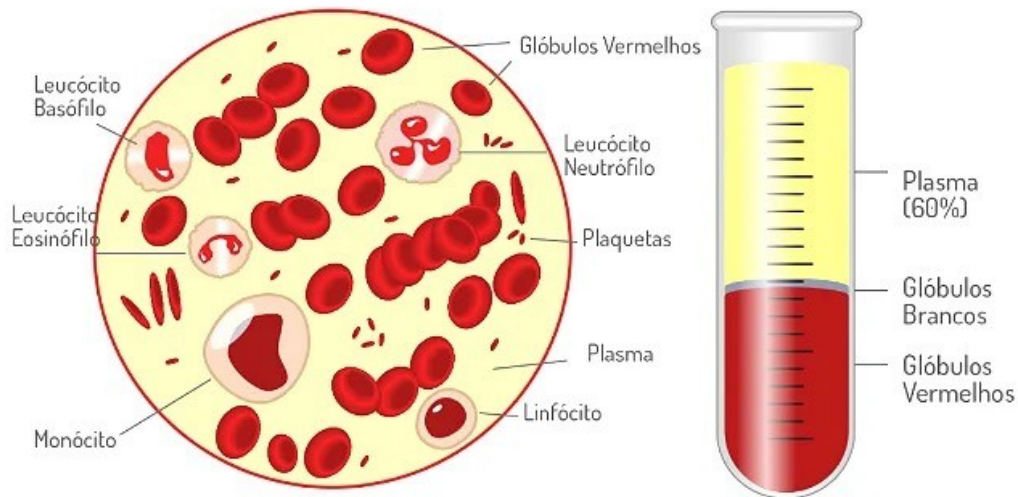
2. **Hemograma**, devido a viscosidade, para ver plaquetas (principalmente).

As plaquetas estão associadas ao primeiro processo inicial de coagulação → hemograma.

Hemograma completo:

- Exame que avalia qualitativa e quantitativamente os elementos celulares do sangue.
- Exame complementar mais requerido nas consultas.
- Fundamental na triagem de saúde.
- Coadjuvante diagnóstico.
- Controle evolutivo de doenças.

Sangue e seus componentes:



Glóbulos vermelhos (contém hemoglobina e transporte de oxigênio, porque temos a hemoglobina)

Plasma

Plaquetas (fragmentos de citoplasma de células; função na coagulação e hemostasia)

Glóbulos brancos (ajudam no combate a infecções; função imunológica)

Capilar

O sangue em volume adulto é de +/- 8% do peso corporal (+/- 5,5L). O seu local de produção é na medula óssea . E a sua principal FUNÇÃO é realizar o transporte, defesa e a hemostasia.



Hematopoese: é onde começa o processo das células → Processo de formação, desenvolvimento dos elementos figurados do sangue.

Coagulograma:

Glicemia e hemoglobina glicada

Hemograma Série vermelha (Eritrogrania)

O que é anemia? É uma deficiência no transporte de oxigênio. E anemia não é considerada uma doença, e sim uma condição que vem como consequência de algo. Como CD é importante que ele saiba que o paciente pode sofrer um desmaio, alguns sais anestésicos não podem ser utilizados, além de anemia interferir na cicatrização, devido a falta de oxigênio no sangue.

Ela está associada à diminuição de algumas hemácias? Sim, pois as hemácias possuem hemoglobina, e ela que faz o transporte de oxigênio. Porém, nem sempre vai ter a diminuição de hemácias, pois depende do tipo de anemia que o paciente possui.

De acordo com a OMS, provavelmente

estão com anemia:

Homens: possui a hemoglobina menor que 13 g/dL.

Mulheres: possui a hemoglobina menor que 12 g/dL.

Gestantes: possui a hemoglobina menor que 11 g/dL.

Crianças menores que 6 anos: possui a hemoglobina menor que 11 g/dL.

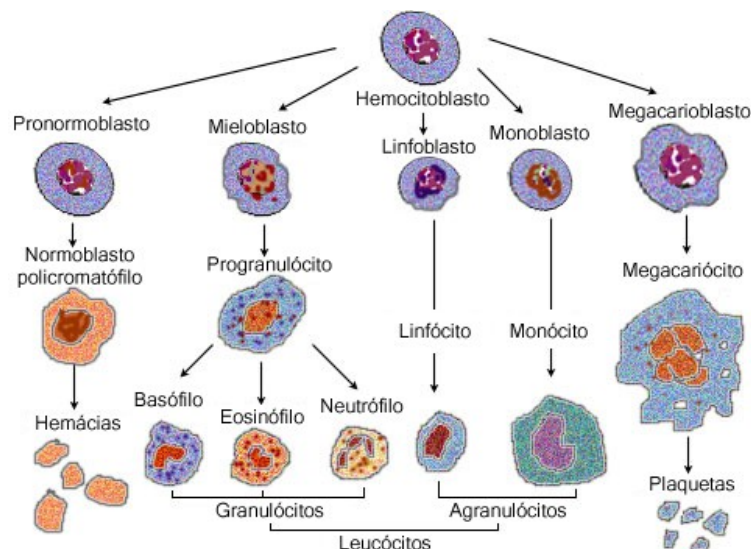
Crianças de 6 a 11 anos: possui a hemoglobina menor que 11,5 g/dL.

Condição na qual o conteúdo de hemoglobina no sangue está abaixo do normal como resultado da carência de um ou mais nutrientes essenciais.

Subdivisão:

Fisiopatogenia/cinética (hipoproliferativa, hiperproliferativa).

Morfologia (macrocítica, normocítica, microcítica).



Temos uma célula progenitora que gera uma linhagem de células, e uma delas é o RETICULÓCITO, ele gera → os ERITRÓCITOS, que são os glóbulos vermelhos e hemácias. Os reticulócitos possuem RNA, que são produzidos na medula óssea, que consequentemente cai na corrente sanguínea → e demora de 2 a 3 dias para remover o RNA que sobrou, e assim temos os glóbulos vermelhos.

Reticulócitos

São eritrócitos recém saídos da medula que ainda contém ácidos nucleicos, RNA ribossômico residual.

Temos uma referência média de 1,43% ou 65.000/uL

RETÍCULOCITOSE = aumento, ou seja, se o paciente está perdendo sangue pode haver aumento da reticulocitose.

Principal motivo: perda de sangue.

Os reticulócitos é um *sinizador* quando temos perda de sangue.

*O ferro que está dentro da hemoglobina, que está dentro da hemácia, perdeu reticulócitos.

Pedimos exames ao paciente dependendo de como está as hemácias. Quando a paciente for do sexo feminino sempre perguntar se está em seu ciclo menstrual. O estresse também pode ser um indício de aumento de reticulócitos. Para pacientes anêmicos temos que evitar a sedação consciente com óxido nítrico, porque usamos o O₂.

A contagem de reticulócitos indica a resposta da medula óssea à anemia.

Hemácias

Glóbulos vermelhos, hemácias ou eritrócitos.

Forma: discos bicôncavos, 7 a 8 µm diâmetro, anucleada. Ela é bicôncava para facilitar o transporte de O₂. É mais fácil de fazer a troca em tecidos. Dependendo do tipo de anemia, a forma dela muda, dificultando a passagem de O₂ e o transporte pelos tecidos.

Hormônio regulador: eritropoetina nos rins e no fígado. A eritropoetina ajuda na regulação na produção de hemácias. Ela é produzida pelos rins e pelo fígado.

Produção: 1ªs semanas de gestação no saco vitelínico. 2º trimestre, no fígado, baço e linfonodos. Último mês e após o nascimento, a medula óssea.

Tempo de vida médio: 120 dias. Isso justifica pedirmos o exame de reticulócitos

Valor normal: 5,3 M/uL homens // 4,7 M/uL mulheres M/uL: é um valor de referência. *Micromol por microlitro.*

Eritrocitocitose: aumento ↑ de eritrócitos.

Eritropenia: diminuição ↓ de eritrócitos.

*Não se utiliza apenas a contagem de hemácias para diagnóstico de anemia, devido a sua fisiopatogenia, tamanho da hemácia, amplitude da hemácia, podendo ser característica de uma anemia macrocítica ou microcítica.

Hemoglobina (Hb)

A hemoglobina é uma proteína presente nas hemácias, constituindo aproximadamente 35% do seu peso.

É um **pigmento** protéico presente no sangue responsável por transportar o oxigênio, levando o dos pulmões aos tecidos do corpo. Este pigmento pode ser mais claro ou mais escuro, tudo depende da quantidade de O₂. Temos que pedir no exame para conseguir ver a concentração de pigmento. Se está menos pigmentado, o paciente pode estar com anemia. **POLICROMAZIA:** quando temos o sangue MUITO pigmentado, fora do

ANOTAÇÕES

02

AULA

Pacientes com Necessidades Especiais (parte 2)

normal, também deve ser analisado.

Duas partes: protéica (globina) e heme (ferro).

Contém 6% de Fe (ferro) do organismo.

Tem uma capacidade de ligar reversivelmente oxigênio.

PONTOS-CHAVE

15,3 g/100mL céls em homens

13,6 g/100mL céls em mulheres

Hematócrito

Mede a porcentagem dos elementos celulares presentes no sangue: **VISCOSIDADE**.

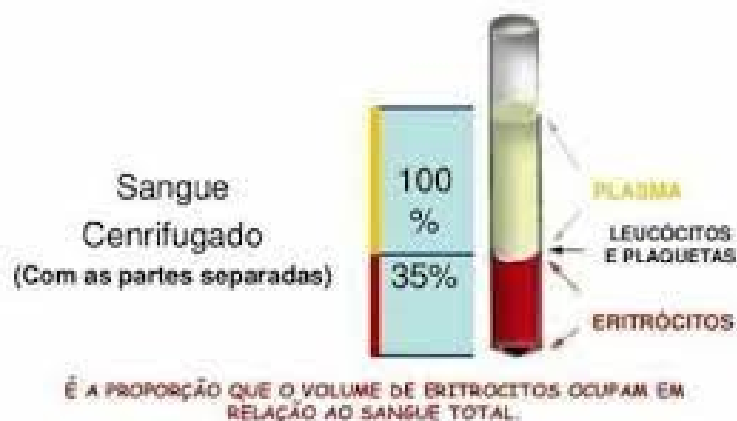
Conseguimos observar através do hemograma.

Um paciente anêmico vai estar com o hematócrito baixo, pois será menos viscoso.

Representa a proporção de glóbulos vermelhos em cada 100 ml de sangue.

A sua porcentagem normal é de 42 a 47%.

O QUE É O HEMATÓCRITO!



Diminuição: anemia, desnutrição, leucemia, sangramento.

Aumento: doença pulmonar, doença cardíaca congênita.

Pode estar relacionado porque precisa realizar trocas gasosas, precisamos de mais O₂.

Volume corpuscular médio (VCM)

Avalia o volume médio de eritrócitos.

Referências: normal é de 87-99 fL para homens e mulheres.

Macrocitose: > 100fL São anemias em que os eritrócitos consistem em macrócitos ovais, com VCM maior do que o normal. **Microcitose:** < 80fL São anemias caracterizadas por baixo VCM e hipocromia. A mais comum é a anemia ferropriva, que deve ser diferenciada das talassemia, e em certas ocasiões, da anemia de doenças crônicas.

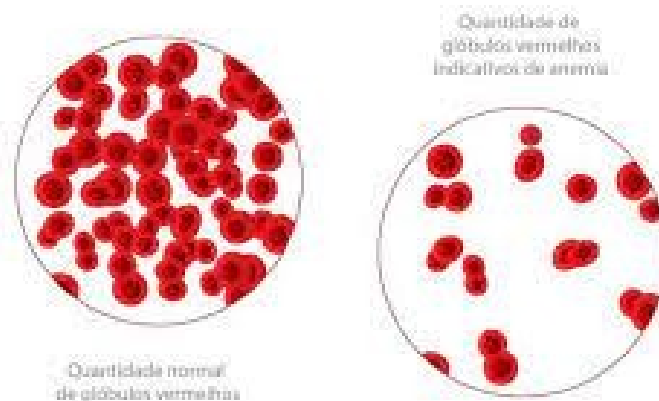
Apesar da alta frequência da anemia ferropriva, os pacientes não devem ser tratados automaticamente com ferro sem antes determinar a causa da anemia.

Diagnóstico diferencial laboratorial de anemias.

Avalia tipos e anemia (macrocítica, microcítica, normocítica). Normocíticas: anemias com o VCM normal.

Correlaciona-se inversamente com a contagem de hemácias (VCM mais baixo contagem mais alta de hemácias e vice versa).

Anemia



Em um círculo possui hemácias maiores e em menor quantidade. Já no outro círculo, possui mais hemácias e em maior quantidade.

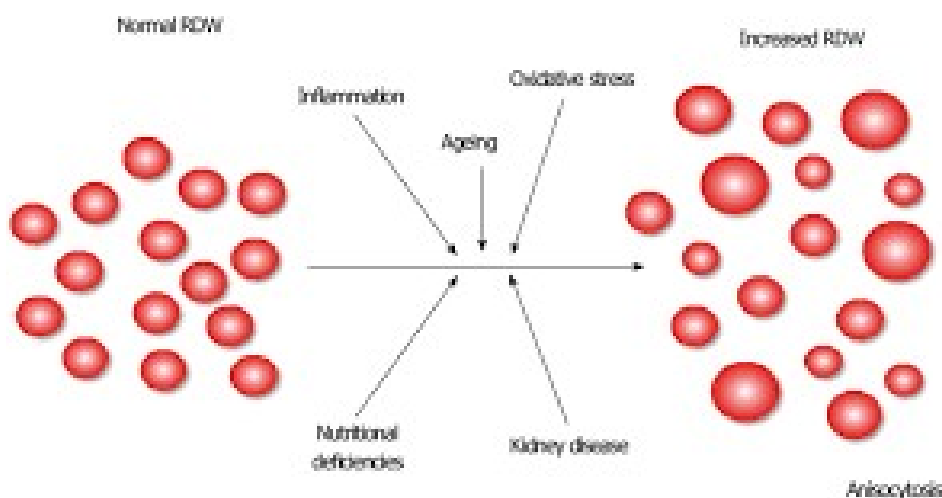
Red Blood Distribution Width (RDW) Índice de anisocitose ou amplitude de distribuição dos eritrócitos

Amplitude de distribuição dos eritrócitos.

Avalia o grau de variação no tamanho das hemácias.

Referências: Normal: 11,5 - 14,5% **Valores abaixo:** raramente são vistos **Valores acima:** ANISOCITOSE (maior amplitude).

Dificulta as trocas gasosas.



Do lado esquerdo temos hemácias iguais e com uma amplitude igual. Já do lado direito, temos hemácias diferentes e com amplitudes diferentes, o que dificulta as trocas gasosas.

Anemia ferropriva: anisocitose.

Tarissemia: RDW normal.

Hemoglobina corpuscular média (HCM)

Quantidade média de hemoglobina por eritrócito (*peso de Hb por eritrócito*).

$$HCM = Hb/Ertrócito$$

Valor de referência: 27 a 32 pg.

Podemos entender se o paciente está desenvolvendo anemia ou não.

Concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM)

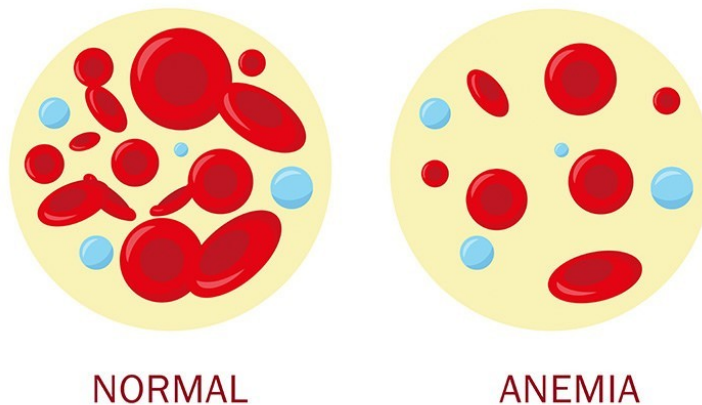
A concentração média (massa/volume) de Hb *nos eritrócitos*.

$$CHCM = HCM/VCM$$

Normal: média 32 - 36%

Hipercromia: 36 - 39% Hipocromia é o aumento na tonalidade avermelhada (hemoglobina) das hemácias e está associada ao aumento da hemoglobina dentro dessa célula.

Hipocromia: < 31% Hipocromia é a redução na tonalidade avermelhada (hemoglobina) das hemácias e está associada à redução da hemoglobina dentro dessa célula.



Como fazemos o diagnóstico da anemia? Existem muitas maneiras de classificar as anemias, porém o diagnóstico diferencial da anemia pode ser estreitado pelo uso do tamanho dos eritrócitos, indicado pelo volume corpuscular médio (VCM) e pela contagem de reticulócitos.

Quando suspeitar de uma anemia?

Crianças

Criança pequena com retardo do crescimento e que não se mostra tão ativa quanto o esperado para a idade.

A anemia detectada com 3 a 6 meses de idade sugere um distúrbio congênito na síntese ou na estrutura da Hb.

Adultos

Sinais e sintomas inespecíficos, como fraqueza, tontura, perda progressiva de energia, palidez e dispneia na ausência de doença cardíaca ou pulmonar grave (pode ocorrer desenvolvimento de ICC franca em consequência de anemia grave)

Sangramento GI ou vaginal prolongado

História familiar de anemia

Icterícia ou urina de coloração vermelha.

Ou seja, ANEMIA: Menor viscosidade sanguínea → menor resistência do fluxo sanguíneo → menos vasos periféricos → AUMENTO DO DÉBITO CARDÍACO (o coração vai ter que aumentar o rbm) Cuidado com a prática de exercícios físicos e risco de sangramento.

Anemia leve:

Hb > 9g/dL e abaixo do valor de referência, que normalmente é 11.

Causa irritabilidade, cafelélia, fadiga e dispnéia a esforços físicos cotinuos.

Possibilidade de angina caso o paciente apresente insuficiência cardíaca congestiva.

Anemia moderada

Hb entre 6 e 9g/dL.

Causa palidez, tonturas e lipotimias (desmaio). Além poder ocorrer taquicardia, dispnéia (aumento da frequência cardíaca), palpitações de fadiga ao menor esforço.

Toda anemia tem relação com o coração? *As vezes, devido a falta de O2.*

Anemia severa

Hb < 6g/dL.

A sintomatologia é presente mesmo no sedentarismo.

Quando esta < de 3,5g/dL a insuficiência cardíaca é iminente.

Anemia megaloblástica

Há uma deficiência de vitamina B12 e/ou do ácido fólico. O ácido fólico, também conhecido como vitamina B9, é uma vitamina solúvel em água que é essencial para o crescimento e desenvolvimento celular. Ele tem um papel importante na produção de hemácias, na síntese de DNA e na manutenção da função cognitiva.

Poliglobulia ou Policitemia

Aumento de glóbulos vermelhos. Lembrando, anemia é a diminuição dos glóbulos vermelhos = hemoglobina.

É uma síndrome. Síndromes mieloproliferativas (policitemia vera).

Situações fisiológicas: altas altitudes.

ANOTAÇÕES

03

AULA

Pacientes com Necessidades Especiais (parte 3)

O tabagista que fuma mais de 20 cigarros por dia, pode ser mais prejudicado.

Hemograma Série branca (Leucograma)

A série branca ou leucograma avalia a imunidade do paciente.

Número total na circulação é uma média de 7.000.uL.

Proteção do sistema: LEUCOCITOSE (aumento das células brancas) LEUCOPENIA (diminuição das células brancas)

Leucogramas — tipos celulares

Vamos ler leucócitos.

Temos:

PONTOS-CHAVE

Neutrófilos 60 - 65%
Linfócitos 20 - 40%
Monócitos 4 a 8%
Eosinófilos 2 - 4%
Basófilos 0 - 1%

A contagem de leucócitos é muito variável na população porém a proporção entre os tipos leucocitários varia pouco de pessoa para pessoa.

Ou seja, **LEUCOCITOSE**, é o aumento da células de defesa. Então possui alguns fatores que atrapalham, como o fumo, obesidade, café em doses altas, leucemia.

A contagem de leucócitos não varia com o ciclo menstrual.

Neutrófilia

É o aumento do número de neutrófilos. Constante em doenças inflamatórias agudas, gerando até mesmo infecções bacterianas.

Os **neutrófilos** fazem a fagocitose, é os primeiros que chegam, ou seja, fazem a função da primeira linha de defesa do organismo.

Referências: o normal é entre 3.700 e 4.100.uL.

NEUTROFILIA (aumento)

NEUTROPENIA (diminuição). É a diminuição do número absoluto de neutrófilos, podendo causar a leucemia.

Referências: moderadas entre 500

1.000uL. As severas < 500uL (agranulocitose — as células são granulares).

Eusínófilos

Eles possuem baixa atividade fagocitária.

Referências: o normal é 500/uL.

EOSINOFILIA (aumento). Ele aumenta ↑ a resposta imunológica a parasitas, aumenta ↑ as reações alérgicas na pele, aumenta ↑ os quadros alérgicos pulmonares, como por exemplo, a asma. Deve ser interpretada com cautela e em conjunto com demais componentes da série branca. Quando temos um processo de alergia, vamos observar a presença de muitos eusínófilos e basófilos, e com os pacientes alérgicos temos que tomar cuidado com a anestesia, tanto o sal anestésico quanto o vaso.

EUSINOPENIA (diminuição). Difícilmente vai acontecer, mas se acontece o tratamento é com altas doses de corticóides, para abaixar as células.

Basófilos

Está associada a reações alérgicas.

Bradicinina, histaminas, serotonina, heparina.

BASOFILIA (aumento).

Colite ulcerativa
Sinusite crônica
Nefrose
Anemia hemolítica
Doença de Hodgkin
Pós esplenectomia

BASOPENIA (diminuição)

Hipertireoidismo
Na gestação
Períodos de estresse
Infecção aguda
Síndrome de Cushing

Monócitos

São os precursores de macrófagos, ou seja, possuem baixa atividade fagocitária no sangue.

MONOCITOSE (> 800/uL) **MONOPENIA** (diminuição)

Linfócitos

Tipo T: 70 - 90%

Tipo B: 5 - 20%

Eles circulam no sangue e na linfa.

Os linfócitos B são os plasmócitos.

Referências: 1.000 a 4.000/uL

LINFOCITOSE (aumento) **LINFOPENIA** (diminuição)

Hemograma Plaquetas

Denominadas plaquetas ou trombócitos.

Possui tamanhos pequenos, forma discoide e inativa, podem ser ativadas para exercer funções de proteção vascular.

140.000 — 360.000/uL

TROMBOCITOSE (aumento). É um fenômeno reacional e não representa, em si, uma doença hematológica. Pode ocorrer:

- Anemias ferropênicas
- Pós hemorrágico imediato
- Em casos de esplenectomia (remoção do baço)
- Neoplasias mieloproliferativas
- Nos dois primeiros anos de vida ocorre frente a estados inflamatórios

TROMBOCITOPENIA (diminuição). Nas grandes hemorragias tratadas com transfusões. Quando há esplenomegalia (ex.: cirrose, esquistossomose, hipertensão portal, etc). Podemos observar até mesmo doenças infecciosas como a HIV, HCV e HBV. E doenças de medula óssea, como leucemias, anemia aplástica, síndrome mielodisplásicas. E até mesmo consequências da quimio e da radio.

HEMOSTASIA. Mecanismo fisiológico, por meio do qual o organismo se defende de perdas sanguíneas ou da solidificação do sangue dentro de artérias e veias, mantendo a sua fluidez e integralidade vascular.

Coagulograma

Componentes do Coagulograma:

- TP = tempo de protrombina
- TPA = tempo de tromboplastina parcial ativada
- INR = razão normatizada internacional (TP paciente / TP normal)

Vamos realizar uma avaliação da hemostasia.

OBSERVAÇÕES:

Nos temos dois tipos de medicamentos, os ANTIANGREGANTES, e os ANTICOAGULANTES ou ANTITROMBOLÍTICO.

ANTIAGREGANTE	ANTICOAGULANTE
Age no começo da hemostasia	Não forma a rede de fibrina e o colágeno final
Vai inibir o processo inicial das plaquetas	Age na cascata
As medicações mais conhecidas são AAS e Clopidogrel	

CASCATA DE COAGULAÇÃO

- Hemostasia Inicial (Primária) — Tampão plaquetário
- AAS
- CLOPIDOGREL

Se o paciente toma até 300mg, não precisamos pedir o exame de coagulação para ver a cascata. Somente o exame de plaquetas inicial. Se o paciente tomar mais que 300mg não vai acontecer a agregação plaquetária então precisamos pedir o Coagulograma. O médico pode passar os 2 remédios juntos (AAS e o CLOPIDOGREL), é o tipo de paciente que



vai sangrar muito. Por isso que não faz sentido nos CD inibir essa medicação, a paciente pode ter uma trombose.

Hemostasia Secundária — Cascata de coagulação

Hemostasia Final — Fibrinólise

Tempo de protrombina (TP)

Avaliação da via extrínseca. Avalia a capacidade do sangue para coagular.

Referência: 11 a 14 segundos.

Possui deficiência de fatores II, VII e X — aumenta o valor do TP.

Aumenta o número de doenças hepáticas.

Monitoramento de anticoagulantes orais, como a Varfarina e Aspirina — *parte inicial da via extrínseca*.

Tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPA)

Avalia a eficiência da via intrínseca na medição da formação do coágulo de fibrina.

Referências: 28 a 33 segundos.

Deficiências de fatores X, XI, XII e do sistema da via comum, que é a intrínseca.

Monitoramento do uso de heparina. É um anticoagulante. BOMBA DE HEPARINA — tem que saber o tempo certo para atender este

ANOTAÇÕES

04

AULA

Pacientes com Necessidades Especiais (parte 4)

paciente, ou seja, no intervalo das hemodiálises, pois a heparina tem uma meia vida de 4h.

Razão Normalizada Internacional (INR)

Teste que aponta a tendência de coagulação do sangue do paciente — razão normalizada.

Aumento do número de doenças hepáticas em estágio de cirrose não compensada.

Aumenta o uso de anticoagulantes, como a varfarina e a aspirina.

PONTOS-CHAVE

1 ou <1 Acima de 1 aumenta o risco de sangramento.

Tempo de sangramento

Simple realização e possui custo baixo.

Tempo de 1 a 3 minutos.

Julgar se pacientes com trombocitopenia 50 e 100.000/uL, ainda possuem hemostasia primária capaz de suportar uma cirurgia proposta.



Teste de glicemia em jejum

O paciente tem que ficar 8hrs em jejum, e faz uma coleta de sangue em laboratório.

Hemoglobina glicada glicemia em + jejum = ver se tem diabetes.

Teste de tolerância à glicose ou curva glicêmica

Determinar níveis de alteração de açúcar no sangue, o paciente deve estar em jejum de 8h00.

O laboratório irá realizar uma coleta de sangue em jejum para a dosagem da glicose, ingere-se a solução de glicose.

A após a ingestão, são realizadas uma ou mais coletas de sangue para novas dosagens da glicose. Estes exame tem maior sensibilidade que a glicemia de jejum, Mas é preciso ficar no laboratório por pelo menos 2h00 para realizar duas coletas de sangue.

Teste da hemoglobina glicada A1c

Valores normais de referencia: < 5,4%

Pré-diabetes: 5,5% 6,4%

Diabetes: > 6,5%

Níveis de A1c acima de 7 estão associados a um risco progressivamente maior de complicações crônicas. Por isso, o conceito atual de tratamento de diabetes define a meta de 7% ou de 6,5% de acordo com algumas sociedades médicas.

Características do ensaio A1c

Modificadores de efeito Com altas doses de salicilatos, vitamina C, E e deficiência de ferro severa.

Rápido, fácil, seguro, validado.

Coagulograma			
Material:	Plasma (citrato)	Coleta:	11/06/2022 - 06:37:06
Liberção:	12/06/2022 - 06:28:19		
Tempo e Atividade de Protombina			
Tempo	11,3	segundos	
Atividade	101,83	%	
Valor de Referência:	70 ate 130 %		
RNI	0,99		
Valor de Referência:	1,00 ate 1,20		
RNI (International Normalized Ratio) para pacientes em uso de anticoagulante oral: Faixa Terapêutica desejável: 2,5 a 3,0 Risco de sangramento > 5,0			
TTPA			
Tempo	28,4	segundos	
Relação paciente/normal	1,21		
Valor de Referência:	0,85 ate 1,20		
Plaquetas	328	Mil/mm3	
Valor de Referência:	150 a 400 Mil/mm3		

Tratamento odontológico de pessoas gestantes

LEI DA LAQUEADURA 14.443/2022	
ANTES	AGORA
Idade 25 anos	Idade 21 anos
Exige consentimento do parceiro	Não exige consentimento
Precisa ter filhos, no mínimo 02 filhos	Não precisa ter filhos
Vedado laqueadura após o parto	Laqueadura pode ocorrer após o parto
	
A lei entra em vigor no dia 05 de Março de 2023	

Adaptações fisiológicas da gestação

Aumento das funções metabólicas
Aumento da produção de estrógeno, progesterona e gonadotrofina
Alteração de peso, metabolismo
Circulação, líquidos corporais
Respiração

AS PRINCIPAIS NA GRAVIDEZ SÃO:

Sistema cardiovascular Alterações circulatórias Alterações sanguíneas
Sistema respiratório
Sistema renal
Sistema gastrointestinal
Sistema endócrino

Sistema Cardiovascular

Ocorre um aumento **no volume ↑ sanguíneo de até 40%**, **↑** no débito cardíaco de 30-40%, **↑** na frequência de batimentos cardíacos, **↑** do volume de eritrócitos de 15 a 20%.

Porém, ocorre a **diminuição ↓** da PA de 100/70mm Hg no primeiro trimestre.

Na gestação a mulher tende a ter uma produção maior de volume sanguíneo (plasma aumenta de volume) pois está carregando um bebê, porém o volume de eritrócitos continua o mesmo de uma pessoa que não está grávida, ou seja, é baixo, e consequentemente é mais fácil de uma mulher grávida desenvolver a anemia transitória (esse tipo de anemia, não tem alteração no feto).

Quando pensamos nas **ALTERAÇÕES CIRCULATÓRIAS** que ocorrer em uma mulher grávida, podemos citar:

Hipertensão crônica

Pessoas gestantes que apresentam HAS prévia. Ou seja, pacientes que já haviam hipertensão.

Hipertensão gestacional

Ocorre no 2º trimestre, pois aumenta a pressão, porque o sangue circula mais.

Pré eclampsia

Pressão alta, edema, visão turva e **PROTEINÚRIA** — mais proteína na urina, mas só consideramos quando começa a apresentar sintomas. 20ª semana.

Eclampsia Gestacional - + convulsões + os sintomas do pré-eclâmpsia.

Risco gestante e para o feto.

Síndrome da hipotensão postural

28ª semana (final do 2º trimestre).

Pré disposição a hipotensão devido a compressão da veia cava.

Hipotensão, náusea, tontura e fraqueza.

Síndrome da hipotensão postura supina



Figura 5.7 • Síndrome de hipotensão supina.

É um tipo de hipotensão postural

Queda abrupta da PA

Bradicardia

Sudorese

Náusea

Falta de ar

Isso ocorre na gravidez, quando a mãe tá deitada de barriga para cima, pode “apertar” a veia cava, então temos que pedir para as grávidas deitarem e levantarem do lado esquerdo.

Comprometimento do retorno venoso ao coração

Compressão da veia cava inferior

Se formos pensar em um o paciente obeso, que possui aumento da gordura visceral, pode comprimir a veia cava, ou seja, pode ocorrer hipotensão supina. Agora se a gordura for externa, não é o suficiente para comprimir a veia cava.

Quando pensamos nas **ALTERAÇÕES SANGÜÍNEAS** podemos ver no **HEMOGRAMA**:

ANEMIA

Volume sanguíneo aumenta mais rápido que a massa de eritrócitos, e

consequentemente há a queda de hemoglobina.

Alteração no ácido fólico e ferro — que ajudam a conter os outros tipos de anemia

Aumento de neutrófilos. Isso ocorre para tentar combater, ou seja, age na defesa. Mas não chega a perder a gravidez por conta disso.

Quando pensamos nas **ALTERAÇÕES SANGÜÍNEAS** podemos ver na **COAGULAÇÃO**:

Fatores de coagulação aumentados (fibrinogênio, fatores de Von Willebrand, VII, VIII, IX e X).

Sistema respiratório

Edema, congestão nasal e epistaxe (*sangramento nasal, devido ao aumento de capilares*)

Aumento de capilares (estrôgeno)

Respiração bucal

Taquipnéia (↑ da frequência respiratória) e dispinéia (*frequência respiratória alterada, ou seja respirando mais rápido*)

Diminuição do volume respiratório reserva

Aumento do útero

Aumento da demanda por O₂.

Sistema renal, gastrointestinal e endócrino

Diabetes gestacional

2-6% das pessoas grávidas

Resistência à insulina, devido as alterações hormonais.

Obesidade, histórico familiar, idade precoce ou avançada.

Alterações gastrointestinais

Diminui a motilidade intestinal porque expulsa menos nutrientes.

Reduz a secreção gástrica.

Alteração no paladar.

ANOTAÇÕES

05

AULA

Pacientes com Necessidades Especiais (parte 5)

PONTOS-CHAVE

Aumento da ânsia de vômito (desidratação e perda de peso).

*Isso ocorre porque o corpo tem que nutrir o feto e a mãe, consequentemente diminui a distribuição de nutrientes.

Alterações hormonais

Gonadotrofina coriônica (início da gestação) manter o corpo lúteo até que a placenta esteja apta a produzir estrógeno e progesterona.

A progesterona ajuda na implantação do embrião, nutrição do feto e glândulas mamárias e indução do parto.

O estrógeno estimula o crescimento uterino, o aumento de tamanho dos seios e o relaxamento dos ligamentos pélvicos.

Somatotrofina é semelhante ao hormônio do crescimento estimula o desenvolvimento do feto.

Ocorre a diminuição a sensibilidade a insulina, aumentando os níveis asmáticos de glicose para o feto.

Alterações bucais na gestação**Resumo por trimestre****1º trimestre**

Ocorre a formação de órgãos e sistemas. Além de ter maior incidência de abortos espontâneos e enjoos.

2º trimestre

Ocorre o crescimento e a maturação do feto. Além de ter tendência a hipotensão supina.

3º trimestre

Continua ocorrendo o crescimento e a maturação do feto. A grávida sente desconforto. Pode ocorrer a hipotensão supina, além de uma frequência urinária aumentada.

Principais alterações na gestação**◆ Manejo Odontológico**

Temos que executar uma anamnese bem detalhada, perguntando a paciente qual o trimestre de gravidez que ela está, os medicamentos, os problemas de saúde. Temos que aferir a pressão arterial e a glicemia. Pensar sempre em consultas curtas, e evitar atendimentos no período matutino, principalmente no primeiro trimestre de gravidez, devido aos enjoos e vômitos. A posição sentada semi supina ou virada para esquerda evita comprimir a veia cava da paciente, principalmente no terceiro trimestre. Sempre estabelecer uma boa relação com o paciente. E realizar orientação de higiene bucal e hábitos alimentares.

1º TRIMESTRE:

Controle de placa
Instrução de higiene oral
Raspagem e polimento
Evitar tratamento eletivo

2º TRIMESTRE

É o melhor momento para se tratar uma grávida
Controle de placa

- Instrução de higiene oral
- Raspagem e polimento
- Tratamento odontológico de rotina

3º TRIMESTRE

- Controle de placa
- Instrução de higiene oral
- Raspagem e polimento
- Tratamento odontológico de rotina

Lembrando que as urgências pode e deve ser realizada em qualquer trimestre. Pois temos que realizar o controle da dor → a dor libera CATECOLAMINA pela supra renais → isso pode prejudicar o feto,

causando até o nascimento prematuro. Além da dor temos que controlar qualquer tipo de infecção. Se puder qualquer tipo de reabilitação extensa e cirurgias evasivas devem ser postergadas para o pós parto.

◆ Radiografias

Evitar exposição no primeiro trimestre, caso seja necessário em caso de urgência usar filmes de exposição rápida, e sempre usar avental de chumbo na paciente.

A exposição a radiação pode causar anomalias congênitas ou retardo do crescimento quando a exposição for maior que 510/cGy (unidade de medida da radiação).

- Rx tórax (0,008 cGy)
- Radiação natural do ambiente (0,004 cGy)
- Série periapical (0,00001 cGy)

◆ Anestesia

Sempre optar com o vaso construtor, para diminuir a dor do paciente, e não correr o risco de perder o feto.

- Retardar absorção do sal anestésico para a corrente sanguínea
- Diminui a toxicidade
- Aumenta o tempo de duração da anestesia
- Diminui o estresse
- Diminui a produção de catecolaminas endógenas (adrenalina e noradrenalina).

Optar por:

- Lidocaína 2% com adrenalina 1:100.000 (primeira escolha)
- Mepivacaína. Absorção mais rápida, porem os estudos sobre isso são inconclusivos.
- Bupivacaína. Tem uma alta cardiotoxicidade.

Contra indicação:

- Prilocaina. Tem a METAHEMOGLOBINEMIA, que causa a alteração no ferro e o transporte de O2 é deficiente causando a CIANOSE FETAL, que é a falha no transporte de O2.
- Articaína. Tem a METAHEMOGLOBINEMIA, que causa a alteração no ferro e o transporte de O2 é deficiente causando a CIANOSE FETAL, que é a falha no transporte de O2.
- Felipressina (vaso). CAUSA CONTRAÇÃO UTERINA! NUNCA!.

◆ Medicamentos

Categoria A	• Estudos controlados em mulheres não demonstram riscos para o feto no primeiro trimestre e a possibilidade de dano fetal parece remota, não havendo evidências de riscos em estudos posteriores.
Categoria B	• Estudos de reprodução animal não tem demonstrado risco fetal, mas não há nenhum estudo controlado em mulheres grávidas.
Categoria C	• Estudos em animais revelaram efeitos adversos no feto e não há nenhum estudo controlado em mulheres. Só deveriam ser prescritos se o benefício justificar o risco potencial para o feto.
Categoria D	• Há evidências de risco fetal humano, mas os benefícios de uso podem ser aceitáveis apesar do risco. Exemplo: Fármacos necessários numa situação de risco de vida ou uma doença grave, onde não existam drogas mais seguras e eficazes.
Categoria X	• Estudos em animais e seres humanos demonstram anormalidades fetais ou a evidências de riscos para o feto baseando-se em experiências humanas, ou ambos, o risco está claramente acima do possível benefício. A droga é contra-indicada em mulheres que estão ou podem ficar grávidas.

Categoria	Risco	Medicações
A	Estudos controlados em humanos não revelam qualquer risco fetal, há uma remota possibilidade de dano fetal	Vitaminas – Ac. Fólico, suplementos... etc
B	Os estudos em animais não demonstraram qualquer risco para o feto, mas estudos em mulheres grávidas não são adequados, assim, existe um ligeiro maior risco para o feto	Paracetamol Antibióticos: penicilinas, azitromicinas, clindamicina, metronidazol Aciclovir, valaciclovir Lidocaina, Anfotericina B
C	Estudos em animais mostram potenciais efeitos adversos fetais, mas o potencial benefícios dos medicamentos podem superar o potencial de dano fetal	Demais AB, Fluconazol (creme), miconazol, corticoides, AINES, propranolol, Enalapril (1o tri)
D	Não há evidência de risco fetal, mas os benefícios potenciais podem superar os riscos	Doxiciclina, Tetraciclina, Citanest, Fluco (VO), cetoconazol, atenolol, captopril, enalapril (2º e 3º tri)
X	O risco supera claramente os benefícios	Codeína, benzodiazepínicos

ANOTAÇÕES

06

AULA

Pacientes com Necessidades Especiais (parte 6)

Droga	Categoria de risco	Risco	Uso durante a gravidez
Anestésicos locais			
Articaína, bupivacaína e mepivacaína	C	Bradicardia fetal	Com cautela
Lidocaína	B	-	Sim
Analgésicos/Antiinflamatórios			
Aspirina	C/D ^a	Hemorragia	Evitar
Ibuprofeno	B/D ^a	Parto atrasado	Evitar no 3º tri
Inibidores da COX-2 (nimesulida, meloxicam)	C	Constricção de ductos arteriais	Evitar
Paracetamol	B	-	Sim
Codeína	C/D	Depressão respiratória	Com cautela
Prednisona	B	-	Sim

Droga	Categoria de risco	Risco	Uso durante a gravidez
Antibióticos			
Penicilinas, azitromicina, clindamicina, metronidazol	B	-	Sim
Tetraciclina	C	Descoloração dentária, formação óssea	Evitar
Antivirais			
Aciclovir	B	-	Sim
Antifúngicos			
Fluconazol	C	-	Sim
Nistatina	B	-	Sim

Droga	Categoria de risco	Risco	Uso durante a gravidez
Sedativos			
Barbitúricos	D	Depressão respiratória	Evitar
Benzodiazepínicos	D	Fendas orais	Evitar
Óxido nítrico	Indeterminado		
Sialogogos			
Pilocarpina	C	-	Sem informação

Os analgésicos:

PONTOS-CHAVE

O paracetamol é o de 1ª escolha.

A dipirona sódica é a de 2ª escolha. Porém não utilizar no primeiro e último trimestre devido a complicações perinatais de agregação plaquetária.

Os opióides são contra indicados devido as anomalias congênitas e depressão respiratória.

Os ansiolíticos:

Barbabitúricos

Benzodiazepínicos

Pode causar fenda labial ou palatal e até mesmo depressão respiratória.

Os antiinflamatórios:

Dexametasona. Dose única de 2 a 4mg

Aspirina e AINES. Constricção de ductos arteriais intra uterinos e hemorragia.

Ibuprofeno. Seguro nos 1º e 2º trimestre, não aconselhado no 3º.

◆ Alterações bucais

Gengivite Gravídica É uma resposta inflamatória exacerbada com fatores irritantes locais e higiene deficiente. A progesterona é aumentada do exudato, e a integridade das células endoteliais e influencia a síntese de prostaglandinas.

Granuloma piogênico Ainda não se sabe se é uma doença periodontal e inicialmente o risco de parto prematuro e baixo peso, porém aumenta as prostaglandinas.

Cáries Alterações alimentares, má higiene bucal e xerostomia.

Doença periodontal Alterações hormonais e higiene bucal.

Erosão dental Causada pelos vômitos

Anemia Falciforme

Doença Falsiforme

É um grupo de anemias hemolíticas hereditárias.

Conjunto de hemoglobinopatias autosômicas recessivas.

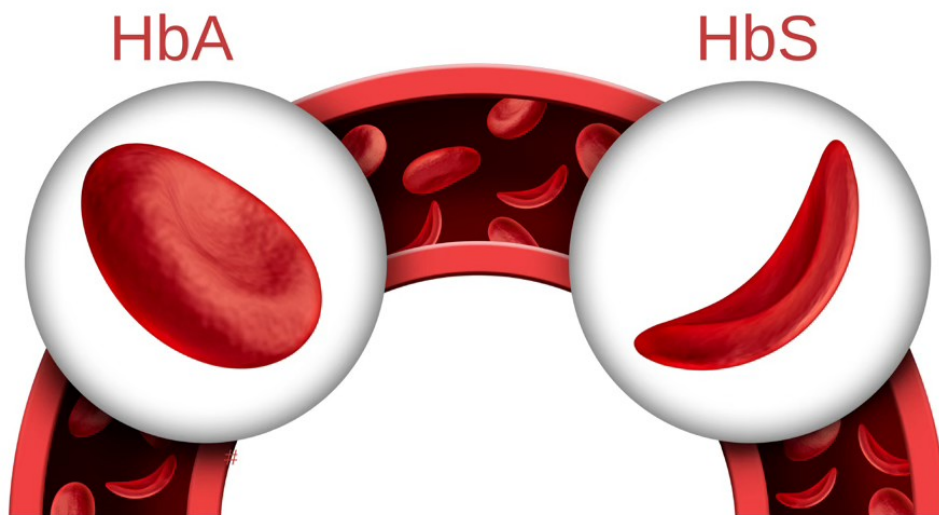
É uma alteração na hemoglobina (Hb) normal. Ou seja passa de HbA → Hbs.

A pessoa tem que ter pelo menos um gene para ter a doença falsiforme.

Quando a pessoa tem a doença falsiforme, ela impede que o oxigênio circule adequadamente.

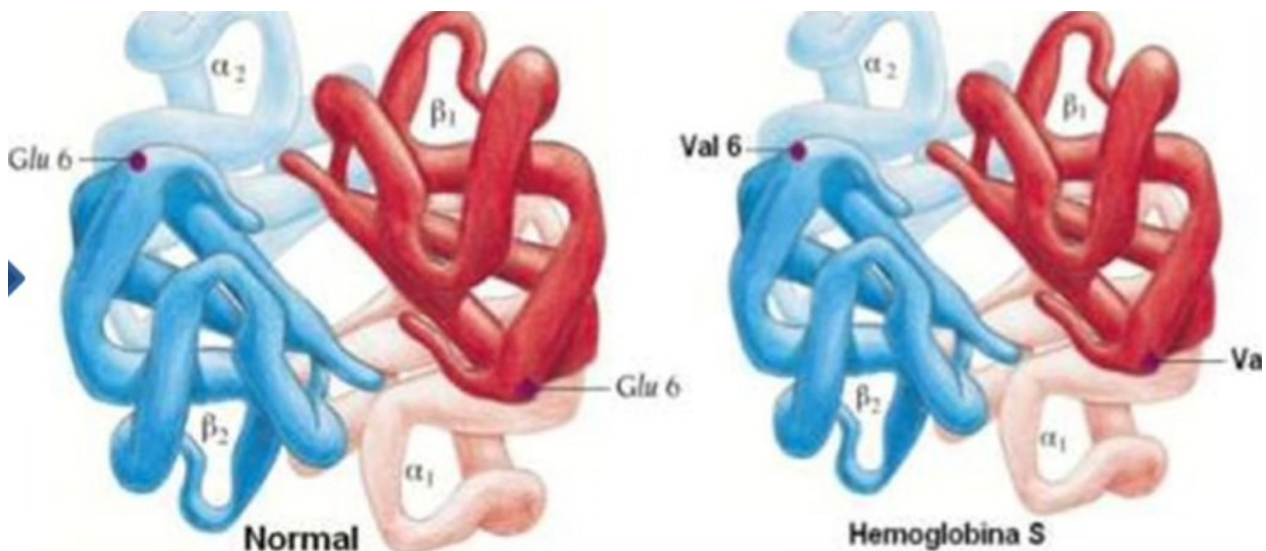
Além de que quem tem a doença quebra os heritrócitos mais rápido. É um grupo de anemias hemolíticas hereditárias.

Como dito na anemia falsiforme o **Hb é modificado**, então o eritrócito sofre.



HbA — heritrócito carrega a hemoglobina. Quando o paciente tem a hemoglobina S, o formato é modificado, devido a falta de O₂ → assim temos a mudança de formato.

Como acontece?



Substituição de um ácido glutâmico por uma valina → muda a sua conformação.

Modificação físico-química da molécula da hemoglobina (HbS).

O que acarreta?

Essa alteração estrutural em situações de desoxigenação (impede que o O₂ circule adequadamente). Ou seja as hemácias passam a ter formato de **foice** → o nome desse processo é a **Falcização**. Que desencadeia reações responsáveis pela variabilidade das manifestações clínicas da DF.

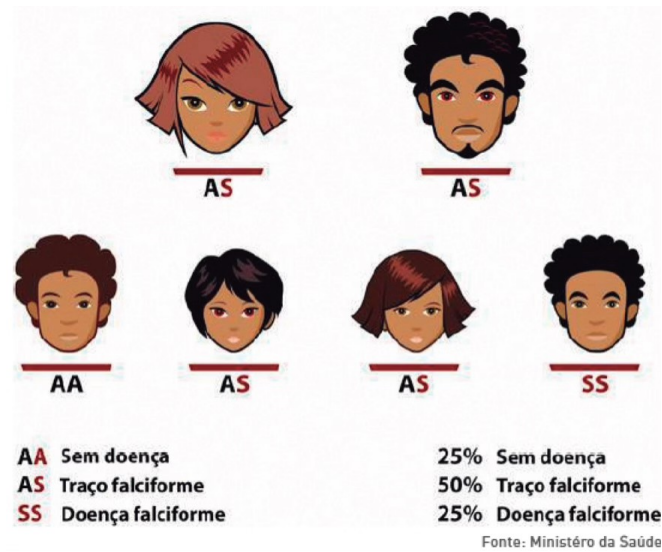
Então para ter a doença falciforme tem que:

- 1 gene HbS
- 1 outro gene relacionado a outro tipo de hemoglobina anormal.
- Doença falciforme tipo S/beta talassemia
- Tipo SC
- Tipo SD
- Tipo SE

A única normal é a HbA, qualquer outro tipo é anormal e pode gerar alguma doença falciforme.

Hereditariedade

Como foi dito é um grupo de anemias hemolíticas hereditárias.



ANOTAÇÕES

07

AULA

Pacientes com Necessidades Especiais (parte 7)

É uma condição homozigótica da anemia falciforme. E quando é uma condição heterozigótica tem um traço falciforme, é um portador assintomático.

Diagnóstico/ Rastreio

Fazemos o diagnóstico através do teste do pezinho quando bebê, é uma avaliação da hemoglobinopatias → eletroforese de hemoglobina.

O teste do pezinho na maternidade se faz quando na alta, a família é orientada a retirar o resultado na maternidade ou por meio do site “Jô Clemente”. Quando no STNN do “Jô Clemente” os casos dão alterados → CRAPH — cadastro e acompanhamento por hematologista. Isso é atenção básica da saúde da criança e do adolescente. É dever do estado garantir o bem estar físico, mental e social da população.

Aspectos demográficos

PONTOS-CHAVE

Mais comum em populações de origem africana devido a mutação genética para proteção a malária, na época, hoje em dia não existe mais.

Pacientes negros (negros e pardos declarados pelo IBGE).

Programa Nacional de Triagem Neonatal estima que nasçam no Brasil.

Estimativas no Brasil

3.500 crianças com doença falciforme/ ano 1:1.000 nascidos vivos.

180.000 mil portadores de traço falciforme/ano

Uma das doenças hereditárias monogênica mais prevalente no Brasil.

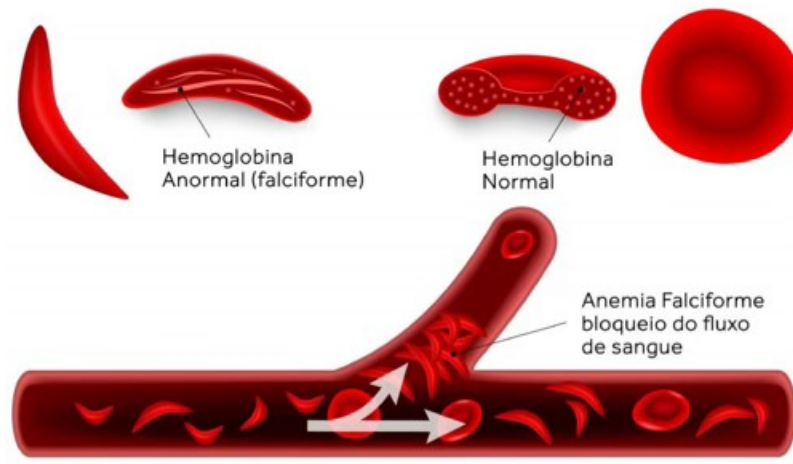
Anemia Falciforme (Hb SS): casos estimados — 25.000 a 30.000.

Traço falciforme (Hb AS):

População Geral: 4% (2% a 8%)

Entre afrodescendentes: 6% a 10%.

Fenômeno de falcização



Condições para a crise:

Baixa tensão de O₂

Desidratação

Acidose (diminui a afinidade pelo O₂)

Estresse na cadeira odontológica, por exemplo Por isso temos que utilizar os anestésicos com vaso. Não podemos usar Prilocaína e nem Articaína.

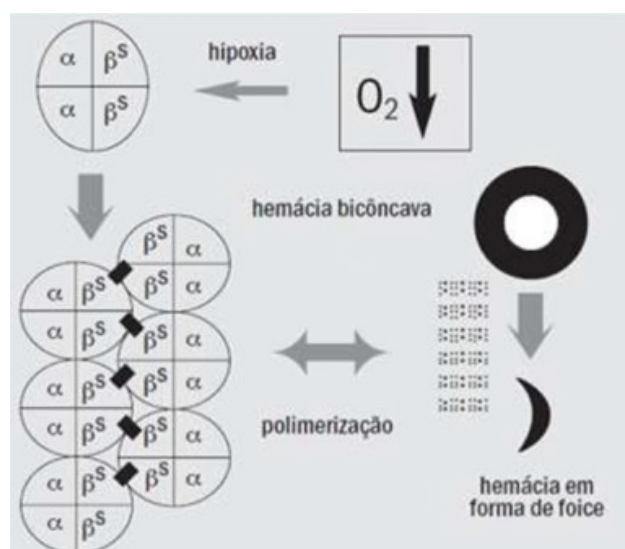
Exercícios físicos

Hipotermia

Infecção

HbS sem O₂ vira HbS

Baixas tensões de oxigênio:



Moléculas de HbS desoxigenadas e unem formando polímeros

A quantidade de polímeros aumenta com a desoxigenação

Fenômeno é reversível com a oxigenação

Isso acarreta a diminuição da vida útil de 120 para 20 dias

Consequências da falcização:

Vasoclusão. Obstrução do fluxo sanguíneo capilar. *Pode ocorrer isso na polpa dentária caso haja lesão de cárie. Se o paciente teve um processo de dor devido a anemia falsiforme, e fizemos o teste de vitalidade, pode ser que ele sinta e de uma reação positiva ao teste, mas não tratar o canal de imediato, realizar o procedimento depois de mais ou menos 1 mês, pois já terá "passado" a crise da anemia falciforme.*

Aspectos clínicos

Manifestações agudas da vasoclusão = desoxigenação :

Crises algícas: quando há falta de O₂

Dores osteoarticulares e abdominais

Surto de 3 até 10 dias

Dactilite (Síndrome Mão-Pé)

Elevação dos níveis de bilirrubina

Manifestações crônicas da vasoclusão

Acidente vascular encefálico

Comprometimento crônico de múltiplos órgãos, sistemas ou aparelhos, como o baço

Insuficiência pulmonar e renal

Alterações oculares (retina)

Desenvolvimento esquelético e puberal atrasados

Fibrose esplênica progressiva Repetidos infartos e trombose atrofia e fibrose do órgão. Persistente agressão esplênica asplenia funcional (maior susceptibilidade à infecções).

Crise aplásica Dsencadeada por infecções virais (parvovírus B19). A infecção viral destrói eritrócitos imaturos. Consequentemente parada da produção de glóbulos vermelhos.

Síndrome torácica aguda Infecção secundária de áreas infartadas no parênquima pulmonar

Insuficiência renal crônica Estruturas glomerulares e tubulares

Alterações osteoarticulares

Alterações osteoarticulares

HIPERPLASIA DA MEDULA ÓSSEA (Formação De Grandes Áreas Medulares E Perda De Trabeculado Fino)
Mecanismo compensatório da anemia hemolítica.

OSTEOPENIA / OSTEOPOROSE Diminuição da densidade óssea

NECROSE ISQUÊMICA Fêmur, tíbia, úmero

OSTEOMIELOTE Vasoclusão à isquemia à necrose à infecção secundária

ARTRITE SÉPTICA

Manifestações da anemia (destruição prematura dos eritrócitos)

Palidez

Icterícia (elevação dos níveis de bilirrubina)

Cálculos vesiculares

Elevação dos níveis dos retículos

Úlceras crônicas

Tratamentos Paliativos

- Transfusões (Hb<6g/dl)
- Hidroxilureia
- Ácido fólico
- Vitamina B12
- Analgésicos
- Antibióticos

Cura

Transplante de células tronco hematopoiéticas. Com uma expectativa de vida 40/60 anos (muito variável).

Alterações orais

- Dor mandibular (21-36%) (vaso-oclusão)
- Sintoma mais comum
- Crises dolorosas generalizadas
- Neuropatia do nervo mentoniano
- Parestesia do lábio inferior
- Necrose pulpar assintomática (vaso-oclusão)
- Câmara pulpar com calcificações (trombose dos vasos sanguíneos)
- Palidez da mucosa (anemia severa)
- Atraso na erupção dentária (diminuição do suprimento sanguíneo)
- Atrofia das papilas linguais (língua lisa) (anemia severa)
- Aumento da severidade da doença periodontal
- Alteração da mineralização (hipomineralização do esmalte e da dentina) (diminuição do suprimento sanguíneo)
- Osteomielite (vaso-oclusão, necrose óssea, crescimento bacteriano)
- Neuropatia do nervo mandibular (vaso-oclusão)
- Achados radiográficos 79-100% (vaso-oclusão)
- Pela hiperplasia (expansão compensatória da porção óssea medular)
- Padrão trabecular grosseiro (osso alveolar)
- Aumento do espaço medular
- Áreas radiolúcidas entre os ápices dos dentes e a borda mandíbula)
- Lesões radiopacas (processo de reparo de áreas infartadas)

Implante deve ser muito bem avaliado!!

- Pela hiperplasia (expansão compensatória da porção óssea medular)
- Crescimento exacerbado/protrusão do terço médio da face
- Expansão do maxilar (diastemas)
- Prognatismo maxilar
- Consequente má-oclusão (grau II)
- Perfil convexo

Manejo odontológico

- Anamnese (verificar sempre se o paciente esta sendo internado muitas vezes)

Condição estabilizada (crônica)

Níveis de hemoglobina acima de 9g/dl e da concentração da HbS inferiores a 50%

Manter boa higiene (infecções podem precipitar crises falcêmicas)

Evitar hipotermia pois causa desidratação → frio pode contribuir para as crises, pois diminui o O₂. Ou seja, sempre controlar o ar condicionado do local

Evitar procedimentos longos, pois pode causar estresse.

Análise radiográfica periódica

Teste de vitalidade pulpar em dentes que apresentarem alguma radiolusência periapical

Crise dolorosa Os **ANALGÉSICOS** são:

Paracetamol Dipirona •

Codeína

ANESTÉSICOS LOCAIS: Com vasoconstritor

ANOTAÇÕES

08

AULA

Pacientes com Necessidades Especiais (parte 8)

Anestesia eficiente diminui a dor e a ansiedade. Procedimentos pequenos e bem planejados. Óxido nitroso e anestesia geral, sempre devemos evitar, pois pode causar hipóxia, ou seja, reduz a oxigenação. Barbitúricos são contra indicados. Depressão do sistema respiratório.

ANTIBIOTICOTERAPIA

Só iremos utilizar em casos específicos

PONTOS-CHAVE

- Infecção local
- Baixa neutrofilica
- Hb muito baixo
- Paciente muito debilitado

Não são totalmente contraindicados, mas devido aos possíveis riscos de complicações ósseas, devem ser vistos com indicação precisa para cada caso:

- Ortodontia
- Movimentos lentos
- Periodicidade maior (espaço para ativação de no mínimo três semanas)
- Implantodontia

Doença de Parkinson e Doença de Alzheimer

São doenças que causam a demência. A melhor forma de evitar é a alimentação, quem disse isso foi a Dieta do Mediterrâneo.

Essas doenças vem ocorrendo devido ao envelhecimento populacional. A população mundial idosa vai ultrapassar de 841 milhões em 2014 para 2 bilhões até 2050. Brasil: 5ª população mais idosa do mundo. 2030: o número de idosos ultrapassará o total de crianças entre zero e 14 anos.

Demência

A demência não é somente um tipo de doença, é considerada uma **síndrome**, ou seja, não precisa ter envolvimento genético, são determinados sinais e sintomas.

Características:

- Esquecimento ou problemas com a memória
- Problemas de comportamento (agitação, insônia, choro fácil)
- Perda de habilidades adquiridas. Aprendeu algo e esqueceu

10 sinais mais comuns nas demências:

1. Déficit de memória
2. Dificuldades de executar tarefas domésticas
3. Problema com o vocabulário
4. Desorientação no tempo e espaço
5. Incapacidade de julgar situações
6. Problemas com o raciocínio abstrato (como por exemplo, não entende piada)
7. Colocar objetos em lugares equivocados
8. Alterações de humor de comportamento
9. Alterações de personalidade
10. Perda da iniciativa - passividade (não tem iniciativa de fazer nada)

Patologias que causam a demência

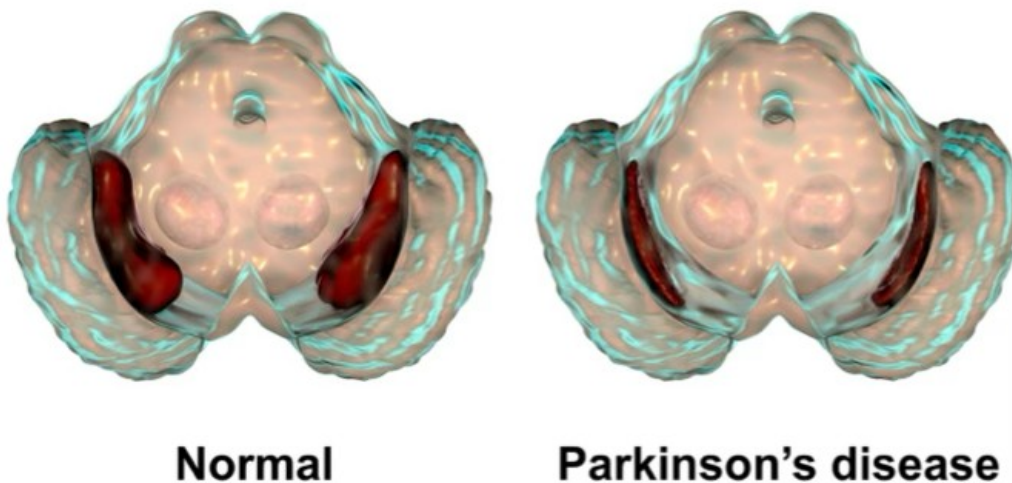
- Demência vascular
- Doença cortical difusa
- Dos corpos de Lewy
- Doença de Pick
- Doença de Huntington
- Doença de Parkinson
- Doença de Alzheimer

Parkinson

É a 2ª doença neurodegenerativa em idosos. É uma doença crônica e progressiva, que **causa a diminuição de dopamina**, portanto afeta os neurônios causando o tremor.

É uma doença MULTIFATORIAL (genética e ambiental) → Ocorre quando os neurônios do cérebro da substância negra (lugar específico do cérebro — *mesencéfalo*), onde é responsável pela produção de dopamina (↓ ela diminui), morrem ou tornam-se não funcionantes.

A **dopamina** é um neurotransmissor, responsável por: aprendizado, memória e controle de movimentos.



Nessa região específica que é o mesencéfalo, os neurônios não funcionam ou perderam a sua função.

Manifestações clínicas

Tremor em repouso das extremidades.

Andar lento (**bradicinesia**) A *bradicinesia* significa: tem uma alteração nos músculos, ou seja diminui a função deles, devido a perda de movimento (movimentos mais lentos) e de hormônios

Instabilidade postural — não consegue parar quieto. Ou seja, nos CD temos que atender em 90°

Rigidez dos membros e do corpo.

Pacientes que possuem a doença Parkinson, devido a diminuição da função dos músculos, normalmente possuem mais o intestino preso, o músculo não consegue realizar os movimentos peristálticos. Esse tipo de paciente não consegue mastigar direito, devido a diminuição da função dos músculo. Podendo ter mais cáries, gengivites. Além de não possuir coordenação motora para escovar os dentes.

- Braços caídos
- Fala indistinta

Olhar parado

Salivação abundante = Sialorreia. Isso tudo é devido a bradicinesia. Sialorreia é diferente de hipossalivação.

HIPOSSALIVAÇÃO = para medir é feito um exame, a Sialometria com remédio.

Dificuldade de deglutição = disfagia. Devido a bradicinesia. Como por exemplo, a dor de garganta é uma disfagia que é diferente de odinofagia, que é a dor para engolir. E os pacientes que possuem parkinson não possuem dor para engolir, e sim a diminuição na função dos músculos.

Cansaço

Insônia

Pernas inquietas

Pele fria

Constipação intestinal

Incontinência urinária

Hipotensão

Redução do piscar dos olhos



O Parkinson pode evoluir para uma demência em pacientes que apresentam esta doença por um tempo mais prolongado, ou que só apresentam parkinson após a idade de 70 anos.

Evolução clínica

ESTÁGIO INICIAL:

Tremores de um lado do corpo (dedos), pioram no estado de excitação e cessam no movimento voluntário. Perda do reflexo postural, rigidez do pescoço e tronco → causando uma possível pneumonia devido a bradicinesia. Falta de mobilidade torácica.

É usado anticolinérgicos (Biperideno, benatropina).

Inibidores de receptação de serotonina (Citalopram, Fluoxetina, Sertralina), também usado em pacientes com depressão. Quando o paciente tem demência pode ser confundido com depressão.

ESTÁGIO INTERMEDIÁRIO:

Agonistas de dopamina.

ESTÁGIO AVANÇADO:

Incapacidade de deambulação, demência. A frequência cardíaca é baixa, porque o coração é um músculo.

É usado levodopa.

Alterações orais

Bradicinesia envolvendo os músculos orofaciais

Tremor e rigidez dos músculos orofaciais

Disfagia (alterações motora de língua e faringe)

Alterações na fala

Disfunção senso motora (propriocepção da mandíbula, localização tátil da língua, gengiva e dentes)

Efeitos colaterais de medicações — xerostomia (sensação de boca seca que é diferente de hipossalivação), síndrome da boca ardente (tem que diminuir a alimentação rica em ácido e tratamento com laser)

Conduta odontológica

Alterações na postura e do controle do movimento (abridor de boca é importante)

Tremor nos lábios, língua e pescoço

Dificuldade de deglutição (disfagia) — sialorréia

Xerostomia

Sedação e contenção física devido a movimentos involuntários e tremores

Alteração à impossibilidade de manter a boca aberta. Normalmente estes pacientes não conseguem usar uma PPR.

Adaptação de acessórios para higiene oral (como por exemplo, o Water Pik) Além de um treinamento do cuidador para ajudar na HO.

ANOTAÇÕES

09

AULA

Pacientes com Necessidades Especiais (parte 9)

Cuidados odontológicos gerais

PONTOS-CHAVE

Anamnese: diagnóstico, implicações sistêmicas e no tratamento odontológico. Sempre temos que perguntar quais medicamentos o paciente toma. Optar sempre por tratamento ART (adequar o meio).

Exame clínico: procurar características do quadro apresentado.

Cuidadores: posição, abridores de boca.

Orientação quanto à dieta

Capacidade de mastigação e deglutição prejudicada

Remoção de restos alimentares

Reforço na Higiene Oral

Alzheimer

Há teorias que o paciente pode desenvolver a doença, como:

1. IDADE: quanto mais avançada a idade, maior a porcentagem de idosos com demência. Aos 65 anos, a porcentagem é de 2-3% dos idosos, chegando à 40%, quando se chega acima de 85-90 anos. 2. IDADE MATERNA: filhos que nasceram de mães com mais de 40 anos, podem ter mais tendência à problemas demenciais na terceira idade. 3. HERANÇA GENÉTICA: já se aceita, mais concretamente, que seja uma doença geneticamente determinada, não necessariamente hereditária (transmissão entre familiares). 4. TRAUMATISMO CRANIANO: nota-se que idosos que sofreram traumatismos cranianos mais sérios, podem futuramente desenvolver demência. Não está provado. 5. ESCOLARIDADE; o nível de escolaridade pode influir na tendência a ter Alzheimer. Ou seja, não consegue desenvolver atividades cerebrais.

6. TEORIA TÓXICA: principalmente pela contaminação pelo alumínio. Nada provado.

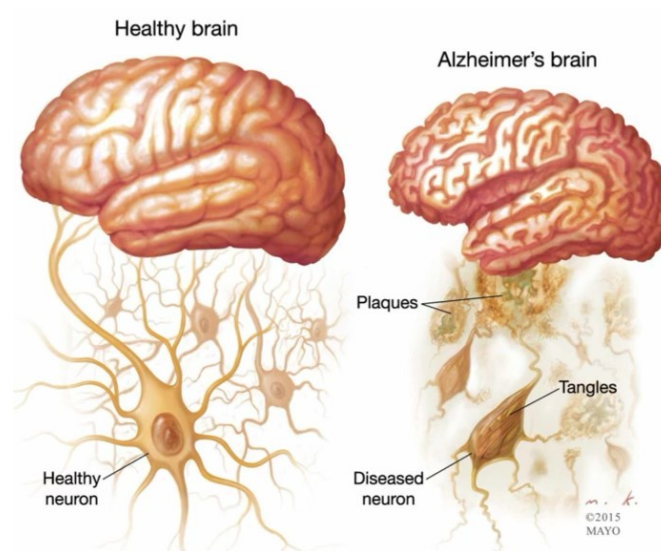
O Alzheimer é uma doença:

Neurodegenerativa;

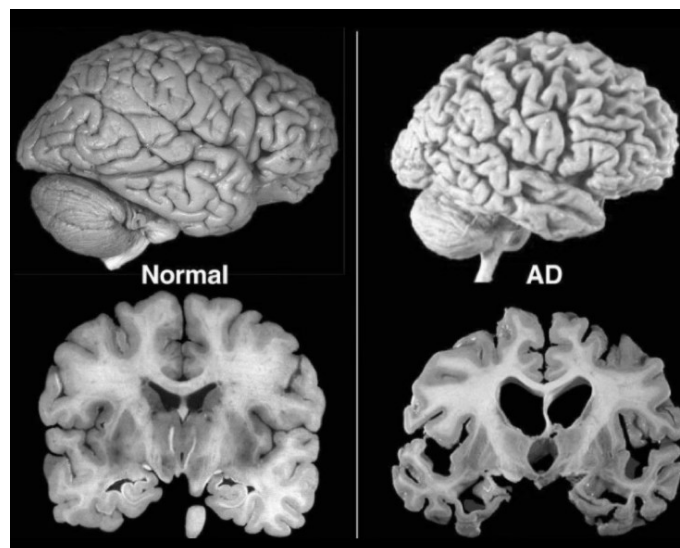
Gradativa;

Sem cura. Os médicos consegue controlar, mas não possui cura.

Como foi dito, o Alzheimer é uma doença neurológica que causa uma desordem progressiva do Sistema Nervoso Central, devido a sua perda difusa de neurônios no hipocampo e no córtex. Gerando o aparecimento de placas amilóides (Beta-amilóides) → substitui os hormônios saudáveis, que formam as placas senis em grande quantidade.



O cérebro destes pacientes começam a “atrofiar”, pois os neurônios desaparecem. Possui influencia na massa do córtex cerebral.



Fatores de risco

Idade avançada (após 60 anos). Possui estudos que dizem que se fizer o exame com 20 anos já consegue saber se pode ou não ter a doença. Mas temos que lembrar que é uma doença hereditária e genética (maior probabilidade de ser genética).

Diminuição na atividade física e mental.

Hipercolesterolemia. Colesterol alto.

HÁS — hipertensão.

Alterosclerose.

Trauma craniano.

Estilo de vida.

Evolução clínica

Perda de memória. É diferente de pessoas que possuem autismo.

Afasia (perda de linguagem). Estes pacientes esquecem as palavras, não conseguem lembrar de seus sinônimos.

Deterioração psicossocial → não conseguem se relacionar.

Incapacidade de julgamentos e decisões.

Alterações comportamentais: alucinações, depressão e agitação.

Mudanças iniciais no cérebro — 20 a 0 anos antes dos sinais clínicos.

Diagnostico de exclusão

Refere-se a uma doença ou condição médica cuja presença não pode ser confirmada com total certeza somente a partir de exames ou testes

Hipotireodismo, acidente vascular cerebral, depressão.

Prejuízo da memória, prejuízo na linguagem, na capacidade cognitiva e social.

Tomografia, ressonância magnética.

Tratamento

Como dito anteriormente, esta doença infelizmente não possui cura. Mas com o tratamento conseguimos:

Melhorar a cognição;

Retardar a evolução;

Tratar os sintomas e as alterações de comportamento;

Calmante e neurolépticos: haldol, neozine, neuleptil, risperidona, melleril, entre outros; Mas tudo isso ainda é muito relativo.

Conduta odontológica

Anamnese

Avaliar e saber o estágio da doença

Alterações na crítica, aprendizado e concentração

Auxílio na higiene da prótese e dos dentes

Planejar um programa preventivo

Sedação em fases mais avançadas Em alguns casos devemos fazer a sedação. Mas podemos optar pela contenção, como por exemplo, dizer ao paciente que você só vai dar uma olhadinha, e você faz uma cirurgia.

Esses pacientes possuem muita: candidíase, quelite angular, ulcerações, xerostomia (sensação de boca seca), lesões de cárie e doença periodontal.

Sempre temos que avaliar a qualidade de vida e fatores que interferem na mesma. Muitos destes pacientes possuem baixa eficiência mastigatória pelo simples fato de esquecer como mastiga, e a maioria precisa de tratamento odontológico.

Osteonecrose dos maxilares

Os principais agentes etiológicos são: por agentes biológicos, traumas, toxicidade química direta, necrose avascular, radioterapia e medicações.

Osteomielite = inflamação dos ossos maxilares com comprometimento do osso cortical e trabecular, geralmente decorre de uma complicação de infecção periapical ou periodontal. Ou seja, se for feito um tratamento endodôntico mal feito, ou deixar um pedacinho de raiz no alvéolo, pode causar osteomielite.

Temos TIPOS de osteomielite, como:

- Aguda;
- Crônica
- Esclerosante Elas irem se diferenciar com o tempo.

Osteomielite Aguda

É um processo inflamatório agudo que se estende através dos espaços medulares do osso e o tempo é INSUFICIENTE para o corpo reagir em presença do infiltrado inflamatório.

A alveolite e a osteomielite não são a mesma coisa. A alveolite começa a partir de uma ação exógena. Já a osteomielite, nos CDs não precisamos mexer para gerar, ela pode vir de consequência de remédios, por exemplo.

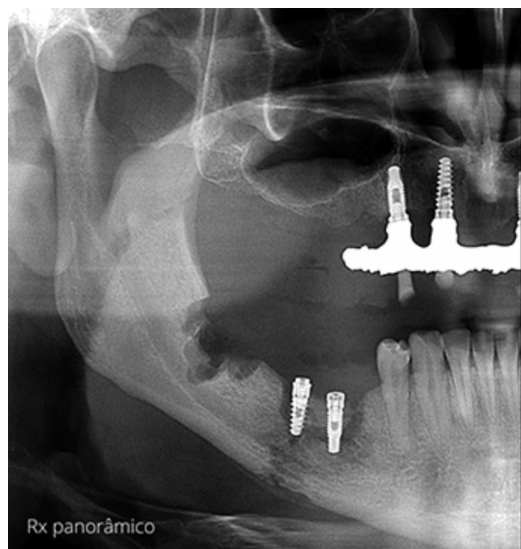
Sinas e Sintomas:

- Febre
- Linfadenopatia (aumento dos linfonodos)
- Leucocitose (aumento dos leucócitos na tentativa de defesa)
- Dor
- Tumefação dos tecidos moles da área afetada

Aspectos Radiográficos:

- Sem alteração radiolúcida
- Área mal delimitada

O organismo pode ou não fazer um sequestro ósseo junto com a lesão.



A diferença de um osso afetado e um saudável é a sua VASCULARIZAÇÃO. Quando o CD for realizar uma cirurgia, precisamos achar o tecido sangrante.

Manejo Odontológico:

- Drenagem do tecido mole
- Antibioticoterapia
- Remoção do sequestro ósseo até achar osso sangrante. Normalmente é necessário enxerto ósseo.

Osteomielite Crônica

É uma evolução da osteomielite aguda ou de outro processo agudo, como por exemplo a alveolite.

A resposta de defesa tecidual leva à produção de tecido de granulação que depois forma uma cicatriz densa, na tentativa de remover a área infectada.

A aparência é de uma esclerose na região do osso.

Primária: abscesso ou fístula.

ANOTAÇÕES

10

AULA

Pacientes com Necessidades Especiais (parte 10)

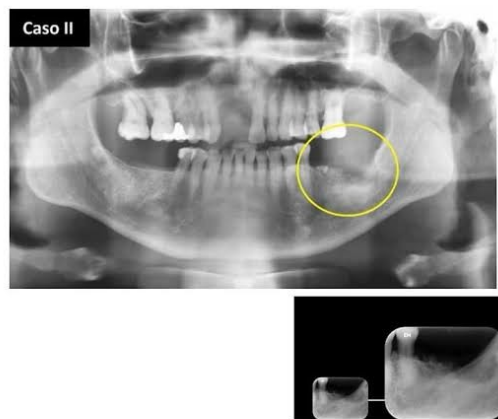
Secundária: com sequestro ósseo (tumefação).

Sinas e Sintomas:**PONTOS-CHAVE**

- Tumefação
- Fístula
- Drenagem purulenta
- Dor intermitente
- Sequestro ósseo
- Fratura com frequência

Aspectos Radiográficos:

- Radiolucidez mal definida
- Irregular
- Sequestros radiopacos



Caso II – A radiografia panorâmica nos mostra imagem de densidade mista, de limites difusos, em processo alveolar da mandíbula, em região correspondente aos dentes 36, 37 e 38, sugerindo Osteomielite Suprativa Crônica, (OSC).
Caso II – A radiografia periapical mostra em detalhes, a imagem de densidade mista e limites difusos em região correspondente aos elementos 36, 37 e 38, sugerindo Osteomielite Suprativa Crônica, (OSC).

Manejo Odontológico:

- Drenagem da secreção
- Remoção de material infectado (tratamento cirúrgico)
- Antibioticoterapia Caso tenha secreção purulenta local, realizar uma profilaxia antibiótica e antibioticoterapia.

Osteomielite esclerosante difusa

Processo infeccioso crônico responsável pela esclerose óssea.

Disseminação bacteriana através do osso medular.

Resposta proliferativa do osso a uma infecção de baixa intensidade e longa duração.

Se entende por uma área óssea mal definida que pode ser confundida com outras doenças ósseas, podendo haver aumento de volume dos rebordos.

Sinais e Sintomas:

- Dor
- Inflamação
- Hiperplasia do periósteo
- Esclerose

Aspectos Radiográficos:

- Área difusa de radiopacidade aumentada



Livro do Neville

Manejo Odontológico:

- Resolução dos focos infecciosos
- Remodelação subsequente — podemos aguardar o organismo remodelar
- Antibioticoterapia

Osteorradionecrose X Osteonecrose Medicamentosa

Possuem mecanismos de ação distintos.

Osteorradionecrose

É a necrose dos ossos gnáticos pós radioterapia.

- Hipovascularidade (pouca vascularização)
- Hipóxia (menos O₂)
- Hipocelularidade (baixa atividade das células)

É **definida** como a perda da mucosa de revestimento e exposição de osso necrótico por um período maior que 3 meses.

Condição progressiva sem tendência à resolução espontânea, ou seja, tem que intervir.

Sempre vai prevalecer a Osteorradionecrose (cabeça e pescoço). Caso o paciente já teve um câncer de mama por exemplo e faz radio e quimio, e aparecer com uma lesão em boca, provavelmente será Osteonecrose Medicamentosa, porque a radioterapia foi feita na mama, não em região de cabeça e pescoço.

Pode **ocorrer** com doses de radiação maiores que 50Gy para tratamento de câncer e cabeça e pescoço. Pode ocorrer devido a:

- Extração dentária (sempre evitar manipulação óssea, porque as vezes o osso já esta comprometido)
- Dentes em más condições
- Manipulação óssea

Por ter sido por **forma** de um TRAUMA, por tempo indeterminado, ou casos após 10 anos da radio de cabeça e pescoço. Ou de forma EXPONTÂNEA, e isso depende da extensão do campo irradiado,

doses altas de RXT. E é mais comum entre 6 meses e 2 anos de radioterapia. 70% a 90% dos casos nos primeiros 3 anos após a radioterapia (13 meses em média). E o menor tempo é de 6 meses, mas é difícil de ocorrer.

Manejo Odontológico:

IDEAL PRÉ RXT

- Preparo odontológico pré RXT. Porém em poucos hospitais possuem este protocolo
- Procedimentos odontológicos invasivos com tempo hábil para cicatrização previamente à RXT (pelo menos 21 dias). Nos CDs temos que ser mais incisivos/agressivos, não da para ser conservador nesta hora.
- Solicitação de RX panorâmico
- Avaliação de terceiros molares (o paciente não pode ir para radioterapia com pericoronarite)
- Adaptação de próteses
- Remoção de focos infecciosos
- Planejamento odontológico mais agressivo

PÓS RXT

Aqui nos CDs devemos ser mais conservadores porque o tratamento é mais invasivo.

- Controle de cáries de radiação (hipossalivação). As cáries de radiação são difícil de serem tratadas, isso devido a hipossalivação, onde muda a textura da dentina, que fica muito porosa
- Prevenção com flúor diário, assim mudamos o pH da saliva
- Planejamento odontológico mais conservador
- Evitar procedimentos cirúrgicos
- Quando o procedimento cirúrgico for inevitável fazer sob antibioticoterapia. E caso tenha secreção local, realizar a profilaxia antibiótica. Se não pode dar sepse.

OSTEORRADIONEKROSE JÁ INSTALADA

- Debridamento e irrigação até achar a área sangrante com antimicrobianos
- Remoção do osso necrótico
- Antibioticoterapia

Manejo Odontológico:

- Pentoxifilina (irriga) e Tocoferol + antibioticoterapia (tratamento conservador)
- Dependendo da extensão realizar procedimento CCG, podendo associar com laser.

Osteonecrose Medicamentosa

É a necrose dos ossos gnáticos pós medicação

- Desregulação do metabolismo ósseo

Apoptose (morte celular) dos osteoclastos, que absorvem o osso → gerando uma redução da capacidade de remodelação óssea (para manter a densidade)

Ela pode ocorrer por 3 motivos:

Corticoides sistêmicos de uso prolongado
Bisfosfonatos
Anti-angiogênicos

Ela é **definida** como osso exposto na região maxilofacial que não cicatriza dentro de 8 semanas. Sem história de radioterapia prévia a região craniofacial (considerando mais a Osteorradioneecrose).

Ela pode **ocorrer** devido a exposição a bisfosfonatos, corticoides ou agentes antiangiogênicos.

De **forma**:

TRAUMA Exodontias, focos infecciosos bucais, próteses mal adaptadas, colocação de implantes, movimentações dentárias e ortodontia.

EXPONTÂNEA

Corticosteróides

MECANISMO DE AÇÃO

Diminuição da densidade mineral óssea
Maior causa de osteoporose secundária
Alteração no processo de remodelação óssea porque os osteoblastos que fazem a matriz são induzidos a apoptose
Redução da síntese de colágeno — osteoclastogênese induzida, ou seja, aumenta a produção de osteoclastos que tiram a matriz

RISCO PARA O PACIENTE

Corticóide maior que 20mg/dia por muito tempo
Dose cumulativa maior que 2000mg
Acomete mais ossos longos devido a qualidade óssea que é mais trabecular

Bisfosfonatos

MECANISMO DE AÇÃO

Os **OSTEOCLATOS**, fazem a inibição da formação / recrutamento e a indução da apoptose, morte celular programada.

Os **OSTEOBLASTOS**, fazem o estímulo da atividade, ou seja, manter a densidade óssea de qualidade, um comprometimento da remodelação óssea.

As **CÉLULAS ENDOTELIAS**, fazem a diminuição da formação de tubos capilares, redução de vasos sanguíneos,

ANOTAÇÕES

11

AULA

Pacientes com Necessidades Especiais (parte 11)

ou seja, menos sangramento local faz com que tenha necrose.

O mecanismo de ação faz a incorporação óssea, afinidade à hidroxiapatita (pode ser que vá para região de maxila e mandíbula). Além de os Bisfosfonatos terem uma meia vida de 1 a 12 anos.

PONTOS-CHAVE

120 dias para zolendronato

300 dias para pamidronato

12 anos para o alendronato

INDICAÇÃO DA MEDICAÇÃO

Osteoporose

Doença de Paget

Osteogênese imperfeita

Câncer de mama e próstata

Metástases ósseas

Mieloma múltiplo onde afeta os ossos

CARACTERÍSTICAS DOS BFS DISPONÍVEIS NO MERCADO BRASILEIRO.						
Genérico	Comercial	Nit	Indicações	Dose	Potência*	Via
Etidronato	Didronel	não	Paget	5 mg/Kg/dia 400 mg/dia	1x	IV
Tiludronato	Skelid	não	Paget	400 mg/dia	10x	Oral
Clodronato	Bonefos	não	Neoplasias	300 mg/dia IV	10x	IV/Oral
Pamidronato	Aredia	sim	Paget/Neoplasias	60 mg	100x	IV
Alendronato	Fosamax Alendil Recalfe Endrox Cleveron Osteoral Osteoform Osteonan Osteotrat Osteofar Bonalen Endronax Minusorb	sim	Osteoporose Paget	Osteoporose 70 mg/sem. 10 mg/dia Paget 40 mg/dia por 6 meses	500x	Oral
Ibandronato	Bondronat Boniva	sim	Osteoporose	150 mg/mês	1.000 x	IV/Oral
Risedronato	Actonel	sim	Osteoporose	35 mg/sem. 5 mg/dia	2.000 x	Oral
Zoledronato	Zometa/Aclasta	sim	Paget/Neoplasias	5 mg Dose única	10.000 x	IV

Nit= Bisfosfonato nitrogenado IV= Intravenosa * Potência relativa ao Etidronato

INCIDÊNCIA ENDOVENOSA

1% a 12% (tipo, posologia, patologia, tempo de uso)

INCIDÊNCIA ORAL

Muito baixa (1/10.000 a 1/100.000 paciente por ano)

A maioria toma para manter a densidade óssea

Antiangiogênicos

Interferência na angiogênese na formação de novos vasos

Processo de reparo ósseo, ou seja, menos vasos, então a cicatrização é alterada

Diminuição do fluxo sanguíneo nos ossos maxilares

Contaminação bacteriana do osso exposto

Manejo Odontológico:

IDEAL PRÉ UTILIZAÇÃO DOS MEDICAMENTOS

Preparo odontológico
Procedimentos odontológicos invasivos com tempo hábil para cicatrização
Solicitação de RX panorâmico
Avaliação de terceiros molares
Ajuste de próteses
Remoção de focos infecciosos
Planejamento odontológico mais agressivo

APÓS A UTILIZAÇÃO DAS MEDICAÇÕES (RISCO)

Control de higiene oral
Planejamento odontológico mais conservador
Evitar procedimentos cirúrgicos

CONSERVADOR	INVASIVO	ADJUVANTE
Antibioticoterapia	Remoção do osso necrótico	PRP
Bochechos	Ressecção óssea	Proteína morfogenética óssea 2 (BMP2)
Irrigação	Ressecção por fluorescência	Ozônio / PDT / Laser
		Câmara hiperbárica

Complicações bucais do transplante de células tronco hematopoiéticas

O transplante de medula óssea é um procedimento utilizado para substituir a medula óssea do paciente que não está funcionando adequadamente porque foi acometida por algum tipo de doença.

Fatores relacionados ao número crescente de transplante

Maior conhecimento do sistema imune
Avanço da biociência e da técnica de transplante
Desenvolvimento de drogas imunossupressoras

Indicações

- LMC
- LMA
- LLA
- Esclerose múltipla progressiva
- Anemia aplástica
- Síndromes
- Mielodisplásicas
- Mieloma múltiplo
- Linfoma Hodgkin
- Anemia fanconi
- Artrite reumatoide progressiva
- Anemia falciforme

Tipos

ALOGÊNICO

Células tronco de um doador compatível

AUTÓLOGO

As próprias células tronco do paciente que são tratadas

SINGÊNICO

Exatamento o mesmo do alogênico (gêmeos). Porém tem casos que os gêmeos não são compatíveis.

TMO Alogênico

- Doador compatível (familiar ou redome)
- Coleta e condicionamento das células e do paciente
- Células são infundidas no paciente, semelhante a transfusão de sangue

TMO Autólogo

- Mobilização e coleta de células tronco
- Células congeladas e armazenadas, fazendo o seu condicionamento
- As células são infundidas no paciente, semelhante a transfusão de sangue

Preparo TMO

- Condicionamento e infusão
- Aplasia medular Produção da células do sangue é comprometida. Ou seja, a medula óssea deixa de produzir as células do sangue e fica repleta de tecido gorduroso. Os sintomas da aplasia são decorrentes da falta de produção das células sanguíneas, a queda de glóbulos vermelhos leva à anemia pode causar fraqueza, fadiga fácil e a redução das plaquetas pode causar manchas vermelhas na pele, equimoses e sangramento em gengivas, fundo do olho ou outros tecidos. A agranulocitose, ou ausência de glóbulos brancos normalmente provoca infecções que ameaçam a vida.
- Recuperação medular e a pega da medula

O **CONDICIONAMENTO**, se faz com altas doses de quimioterapia, do 4-7 dias antes do dia 0, que é o dia de infusão. Nesta etapa ocorre a destruição da medula óssea doente, além da imunossupressão irradiação corporal total. Normalmente o paciente fica mais submetido a **mucosite**, devido a alta taxa de infecção, então o CD pode

fazer tratamentos preventivos com laser.

Durante a **APLASIA MEDULAR**, ocorre a PANCITOPENIA (o paciente fica pancitopenico), incapacidade de produzir as hemácias, leucócitos e as plaquetas. Isso ocorre entre o dia 14-12. O melhor seria se ocorresse a aplasia medular antes do transplante.

PANCITOPENIA = trata-se da redução de todas as linhagens de sangue periférico, ou seja, o valor da hemoglobina, leucócitos e das plaquetas encontram-se abaixo do intervalo de referência normal. Todas as células ficam zeradas, para conseguir receber a medula.

Como fazer a contagem dos dias no condicionamento do tx de medular:

4 -3 -2 -1 → condicionamento para infusão de células. Esse condicionamento pode vir até -7

7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 Nessa fase o CD é indispensável devido ao protocolo de laserterapia, dito anteriormente



Na etapa da **RECUPERAÇÃO MEDULAR**, ocorre a enxertia medular ou a pega do transplante, e os neutrófilos devem estar em uma contagem de 500/ mm², porque a pega da medula ocorre quando esta acima deste valor de referência.

Manejo Odontológico

Fase 0 ou fase pré transplante

- Avaliação odontológica criteriosa
- Remoção de focos e possíveis focos de infecção
- Reestabelecimento da saúde bucal

Entre a fase 0 e a fase 1, ocorre a **ABLAÇÃO DA MEDULA**, a sua infusão, que ocorre no dia zero.

- Doença de base
- Medicações em uso
- História médica e odontológica
- Avaliação laboratorial
- Hemograma
- Coagulograma

Quando ocorre o **nadir da droga** (que é o tempo de menor contagem de leucócitos após o regime quimioterápico), as células vão subir novamente, e o CD pode fazer um procedimento odontológico invasivo e devemos ser agressivos no pós.

Após D 0 Fase 1 Fase 2

Pode ocorrer algumas manifestações bucais, em forma de lesões virais, como:

- Herpes vírus
- CMV (citomegalovírus)
- Herpes Zoster
- EBV (ebola vírus)

Podemos fazer o tratamento com laser e medicação (galociclovir EV)

O paciente não tem condição de fazer uma biópsia, vamos fazer através da citologia, pois deve ser rápido.

Além das virais, temos as bacterianas, como periodontite e cáries.

ANOTAÇÕES

12

AULA

Pacientes com Necessidades Especiais (parte 12)

Além de que podem surgir:

PONTOS-CHAVE

Xerostomia
Disgeusia (alteração do paladar)
Mucosite
DECH = GVHD — doença do hospedeiro contra o hospedeiro.

Nos CDs quando se trata de uma **xerostomia**, devemos aumentar a ingestão de líquidos, fazer bochechos com glicerina, utilização de vitamina E e a saliva artificial.

A **Disgeusia**, não possui tratamento, devemos apenas acompanhar, orientar o paciente devido a sua alteração temporária. A Disgeusia, desenvolve a inapetência, ou seja, a vontade de comer.

A **mucosite**, gera uma reação tóxica inflamatória que pode afetar todo TGI como uma complicação frequente do tratamento antineoplásico. Ela afeta 75-99% dos pacientes com altas doses de quimio. Ela inicia 10 dias após o condicionamento. E a sua maior intensidade é no dia +7 -D +14. Com uma persistência de 2-3 semanas.

O paciente começou um condicionamento no D-4. Qual dia terá a maior probabilidade de ter mucosite? Após 10 dias a partir do dia do condicionamento, ou seja, no dia 06 ele terá maior probabilidade do início de mucosite.

Suas **características clínicas são**: áreas eritematosas, placas brancas elevadas e descamativas, além de ser uma úlcera dolorosa. **Sintomatologia**: Além da dor o paciente sente o aumento da sensibilidade a alimentos quentes e condimentados, tem uma sensação de queimação, dor intensa ao falar, comer e engolir, portanto tem dificuldade de se alimentar.

De acordo com a OMS: Grau 0 - sem alterações Grau 1 - eritema, irritação, dor Grau 2 - eritema, úlceras, pode alimentar-se com sólidos Grau 3 - úlceras requer somente dieta líquida Grau 4 - impossível a alimentação

Nos CDs temos que:

Tópico	Sistêmico
Higiene bucal rigorosa	Analgesia potente
Soluções bactericidas	
Laser terapêutico e profilaxia	

A **DECH**, é uma complicação que ocorre pela ativação de células T em resposta a moléculas do complexo de genes de histocompatibilidade principal (MHC) alogênico subsequente a um transplante de medula óssea (TMO) histocompatível. Ou seja, só pode acontecer quando o paciente fizer o transplante alogênico. A DECH, pode ser aguda ou crônica.

Ela afeta até 50% de todos os pacientes pela boca, pele, olhos, TGI e fígado. Além de causar eritema, erosões, úlceras, estrias brancas, mucocelos, xerostomia e dor.

DECH AGUDA → dermatite; hepatite (icterícia); gastroenterite)dor abdominal e diarreia).

DECH CRÔNICA → síndromes multi-órgãos; inflamação; atrofia; fibrose.

Os **sinais e sintomas da DECH ORAIS** são: eritema, placas, pápulas, estriações brancas, pseudomembranas, úlceras, mucocelo, fibrose, alterações do paladar, xerostomia, dor, desconforto com alimentos apimentados. Além

de possuir um processo inflamatório específico, como a mucosite líquenoide de interface.

O **diagnóstico da DECH** é clínico, fazendo uma biópsia de glândula salivar menor.

E seu **tratamento** são: corticoide sistêmico, corticosteroides tópicos (budesonida, clobetasol, Dexametasona), controle rigoroso de HO, saliva artificial e antimicrobianos tópicos.

Fase 1 e Fase 2

14-21 dias / Pancitopenia / Mucosite / Pega do transplante / Até D+100

Cuidados emergenciais

Manutenção da boa higiene oral

Nesta fase de fizermos algo, o paciente tem grandes chances de morrer

Fase 3

Cuidados ambulatoriais

Cuidados orais

Controle de higiene bucal

Diagnostico de alterações bucais

Tratamento odontológico convencional

Possibilidade de DECH

Usuários de drogas ilícitas

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde) o uso de drogas é considerado um problema de saúde.

Classificação de acordo com a OMS

Uso na vida: o uso de drogas pelo menos uma vez na vida.

Uso no ano: o uso de droga pelo menos uma vez nos últimos 12 meses.

Uso recente ou no mês: o uso de drogas pelo menos uma vez nos últimos 30 dias.

Uso frequente: o uso de droga seis ou mais vezes nos últimos 30 dias.

Uso pesado: uso de droga 20 ou mais vezes nos últimos 30 dias.

Quanto a frequência do uso de drogas

Não-usuário: nunca utilizou drogas.

Usuário moderado: utilizou drogas no último mês, mas o consumo foi menor que uma vez por semana.

Usuário moderado: utilizou drogas semanalmente, mas não todos os dias, durante o último mês.

Usuário pesado: utilizou drogas diariamente durante o último mês.

Consequência do uso de drogas psicotrópicas

1. Consequências físicas, onde limita o paciente em relação a mobilidade. 2. Consequências socioeconômico-culturais, ou seja, a pessoa não consegue se socializar. 3. Consequências mentais 4. Consequências legais

Classificação das drogas

Lícitas (álcool, cigarro).

Ilícitas (produção e distribuição proibidas)

As drogas ilícitas mais consumidas no Brasil são: Crack, Cocaína, Heroína e Maconha.

Naturais (extraída de plantas) -maconha. Muitos fazem o uso para controle de doenças, e por isso temos que saber como fazer o manejo destes pacientes.

Sintéticas (produzidas em laboratório) -anfetaminas.

Semissintéticas (sintetizadas em laboratório e a partir de plantas) -cocaína.

OBS: paciente que faz o uso todos os dias temos que fazer um controle da pressão arterial durante a cirurgia.

Como as drogas agem no sistema nervoso central:

PSICOATIVAS (depressora): ação sobre o SNC (barbitúricos, benzodiazepínicos, opiáceos, etanol e inalantes). Essas drogas vão deprimir o SNC.

PSICOATIVAS (estimulante): ação sobre o SNC (cocaína, crack e anfetamina).

PERTURBADORAS: pode ter os dois efeitos, depressora e estimulante. Como a maconha, medicamentos anticolinérgicos.

PSICOTRÓPICAS: capazes de causar dependência (benzodiazepínicos, maconha, derivados da coca, inalantes, tabaco, anticolinérgicos e o álcool).

Anfetamina

Tem maior duração que a cocaína.

Perda de peso, déficit de atenção, narcolepsia (sono excessivo) e resistência ao tratamento de depressão → *sinais e sintomas* que pode ocorrer com um paciente usuário.

Apresentação: via oral, intranasal, intravenosa ou por inalação ao fumar.

ANOTAÇÕES

13

AULA

Pacientes com Necessidades Especiais (parte 13)

Manifestações clínicas

PONTOS-CHAVE

- Hipertensão e AVC
- Taquicardia / arritmia
- Úlceras na pele
- Perda de peso
- Movimentos repetitivos involuntários
- Comportamento agressivo e convulsões

Manifestações bucais

- Pobre higiene oral
- Xerostomia
- Cárie, devido a acidez, o pH é modificado
- Bruxismo
- Doença periodontal, causando perdas dentárias
- Trismo (efeito colateral do MD). Esse tipo de paciente quando esta sob efeito da droga tem a tendência de apertar os dentes
- Ulcerações e erosões devido a acidez

Nós CDs temos que realizar tratamento odontológico pelo menos 08 horas após a última administração da droga. Devido aos picos no sangue que são mais intensos de 30 a 60 minutos, podendo durar até 08 horas, e em altas doses até 24hrs. Nestes pacientes mesmo que não for anestésiar tem que esperar 08 horas devido a descarga de adrenalina. Nestes pacientes há perigo de isquemia cardíaca e arritmia cardíaca. As anestésias locais com adrenalina potencializa a resposta dos órgãos inervados pelo sistema nervoso simpático, podendo causar AVC, infarto e ri-se hipertensiva. Então o melhor anestésico de escolha é a felipressina como vasoconstritor, pois a sua ação local é exógena, ou seja, não produzimos no organismo como a adrenalina. Paciente que é usuário de ecstasy, "ataca" a gengiva, afeta a mucosa com fenestrações → a gengiva é o local de maior absorção. Dependendo do tipo de droga que o paciente usa as suas digitais ficam

amareladas, muito importante para diagnóstico.

Cocaína e Crack

- Meia vida plasmática de 1h.
- Apresentação: via oral, intranasal, intravenosa ou por inalação ao fumar.
- O crack tem um maior nível de cocaína no sangue.

Manifestações clínicas

- Rinite, sinusite, bronquite, garganta inflamada (rouquidão)
- Erupção em torno da área nasal
- Perfuração do septo nasal
- Hipertensão
- Taquicardia/arritmia
- Perda de peso
- Tremores e espasmos musculares
- Convulsões
- Náuseas e vômitos

CRACK E A GRAVIDEZ

Chega à corrente sanguínea aumentando o risco de complicações para a mãe e para o bebê. Para a MÃE ocorre o aumento do risco de descolamento prematuro de placenta, aborto espontâneo e redução da oxigenação uterina. Para o BEBÊ ocorre a redução de crescimento fetal, o peso e o perímetro cefálico ao nascimento. Riscos de mal formação congênita, risco de morte súbita na infância, atraso de desenvolvimento. Essa criança terá que ser acompanhada a vida toda, ela basicamente nasce viciada e entra em abstinência quando nasce.

Manifestações bucais

- Necrose da mucosa oral
- Perfuração de palato
- Úlceras bucais
- Leucoplasias (lesões esbranquiçadas)
- Candidíase
- Xerostomia
- Péssima condição bucal
- Cárie
- Doença periodontal

Manejo odontológico → Crack e Cocaína

O paciente usuário não deve receber tratamento odontológico por pelo menos 06 horas após a última administração de cocaína. Pois seu pico no sangue gera em torno de 30 minutos até 2h. Este tipo de paciente corre risco de isquemia cardíaca e arritmia cardíaca. Tendo em vista que as anestésias locais com adrenalina potencializa a resposta dos órgãos inervados pelo sistema nervoso simpático, podendo causar AVC, infarto e crise hipertensiva. Então, o melhor anestésico de escolha é a felipressina como vasoconstritor.

Maconha

- Muito mais potente que na década de 60.
- Droga beta-adrenérgica simpatomimética e parassimpatolítica.
- Inalação ao fumar ou ingeridas oralmente. Ou seja, age no SNC.
- Intoxicação: ansiedade, paranoia, sentimento alterado de tempo e distância.

Manifestações clínicas

- Bronquite
- Sinusite
- Faringite
- Laringite
- Pupilas dilatadas
- Edema
- Deprime o sistema imune
- Sono excessivo

Manifestações bucais

- Cuidado bucal deficiente
- Xerostomia
- Cárie
- Doença periodontal
- Candidíase
- Estomatite nicotínica, devido a quentura para quem fuma
- Retardo de cicatrização

Manejo odontológico

Temos que evitar o atendimento em pacientes usuários que apresentam alguma doença isquêmica do coração ou insuficiência cardíaca, se esta associação for identificada o tratamento odontológico deve ser adiado até o paciente se encontrar estável. Este tipo de paciente pode sofrer hipotensão ortostática (quando deitar muito o paciente, ele pode desmaiar). Evitar o uso pelo menos 1 semana antes do tratamento odontológico, pois com o aumento das cetacolaminas reduzem os leucócitos no sangue, o que interfere na cicatrização. Temos que olhar os sinais vitais e falar para pelo menos ficar sem fazer o uso no dia do procedimento.

Usuários de drogas injetáveis

- Contágio por várias doenças com hepatites e HIV
- No passado acreditava-se que os indivíduos usuários de drogas injetáveis tinham risco aumentado para endocardite infecciosa - profilaxia antibiótica.

ANOTAÇÕES